ATA · OTA · AUSBILDUNG & PRÜFUNG

ATA & OTA Fragenkatalog

203 Prüfungsfragen mit Erklärungen für die Anästhesie- und Operationstechnische Assistenz – von Narkose und Atemweg bis Sterilgut, Instrumente und Lagerung.

Bestehen ist planbar.

ATA · OTA · OP · Anästhesie

203	14	A4
Fragen	Themenbereiche	druckfertig

INHALT

1. ATA: Beruf & Recht
2. ATA: Perioperative Versorgung
3. ATA: Narkose
4. ATA: Atemweg
5. ATA: Monitoring
6. ATA: Medikamente
7. ATA: Patientensicherheit
8. OTA: Sterilität & Hygiene
9. OTA: Aufbereitung
10. … und 5 weitere Bereiche

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So nutzt du den Katalog

Bereich für Bereich üben, dann im Lösungsteil kontrollieren. Erstellt von einem Fachpfleger für Anästhesie & Intensivmedizin.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

1 ATA: Beruf & Recht

13 Fragen

1 **Hauptunterschied ATA vs. Fachpflege Anästhesie?** ●●●

- A ATA darf keine Medikamente
- B ATA = eigenständiger 3-jähriger
- C ATA nur Tagschicht
- D Fachpflege niedriger qualifiziert

2 **Was sind Kernaufgaben einer ATA?** ●●

- A Die eigenständige Assistenz bei operativen Eingriffen
- B Patienten vor, während und nach der Anästhesie betreuen
- C Die pflegerische Versorgung auf der Intensivstation
- D Die Aufbereitung von Sterilgut im Bereich des OP

3 **Welche Aufgabe hat die ATA beim Monitoring?** ●

- A Geräte anschließen, kalibrieren und auf Funktion prüfen
- B Die Messwerte medizinisch interpretieren und behandeln
- C Das Narkoseverfahren festlegen
- D Die Indikation zum erweiterten Monitoring stellen

4 **Welche Aufgabe hat die ATA bei der Atemwegssicherung?** ●

- A Die Narkosetiefe festlegen
- B Den Tubus eigenständig platzieren
- C Material vorbereiten, anreichen und assistieren
- D Die Indikation zur Intubation stellen

5 **Welche Aufgabe übernimmt die ATA im Aufwachraum?** ●

- A Festlegung der Verlegungskriterien
- B Aufbereitung von Sterilgut
- C Überwachung von Atmung, Kreislauf und Bewusstsein
- D Steriles Instrumentieren

6 **Wie viel % des Theorieunterrichts machen ATA und OTA gemeinsam?** ●●

- A 100%
- B 25%
- C 75%
- D 50%

7 **Was ist eine zentrale Aufgabe der ATA bei einer Endoskopie in Analgosedierung?** ●●

- A Die endoskopische Untersuchung selbst eigenständig durchzuführen
- B Die kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern und Sedierungstiefe sowie Notfallbereitschaft
- C Ausschließlich die Reinigung und Aufbereitung der verwendeten Geräte
- D Das Schreiben und Verfassen der schriftlichen Untersuchungsbefunde

8 **Welche Rolle kann die ATA im Schockraum der Notaufnahme übernehmen?**

- A Ausschließlich die schriftliche Dokumentation des gesamten Ablaufs
- B Nur einfache Botengänge und das Holen von benötigtem Material
- C Atemwegsmanagement- und Anästhesie-Assistenz sowie Kreislaufüberwachung im interdisziplinären Team
- D Die Reinigung und Desinfektion des Schockraums nach der Versorgung

9 **Seit wann ist die ATA-Ausbildung staatlich anerkannt?**

- A 01.01.2024
- B 01.01.2020
- C 01.01.2018
- D 01.01.2022

10 **Was ist die Kernaufgabe der ATA im Operationsbereich?**

- A Assistenz bei allen Phasen der Anästhesie
- B Steriles Instrumentieren am OP-Tisch
- C Übernahme der Springertätigkeit
- D Eigenständige Narkoseführung

11 **Wozu dient die ATA-Prüfung und wie ist sie aufgebaut?**

- A Schriftlich und mündlich
- B Schriftlich, mündlich und praktisch
- C Praktisch und Portfolio
- D Nur Portfolio

12 **Was ist ATA-OTA-G?**

- A EU-Richtlinie
- B DKG-Empfehlung
- C Bundesgesetz das ATA und OTA regelt
- D NRW-Landesverordnung

13 **Was gehört zur Vorbereitung des Anästhesiearbeitsplatzes?**

- A Aufbereitung der Instrumente in der CSSD
- B Gerätecheck und vollständige Materialbereitstellung
- C Sterile Abdeckung des OP-Feldes
- D Wundverschluss nach dem Eingriff

2 ATA: Perioperative Versorgung

11 Fragen

14 **Welche Zeichen sprechen für einen relevanten intraoperativen Blutverlust?**

- A Ein ansteigender Blutdruck bei gleichzeitig langsamem Puls
- B Eine rosige, warme und gut durchblutete Hautfarbe
- C Blutdruckabfall, ansteigende Herzfrequenz, blasse Haut und ggf. sinkende Urinausscheidung
- D Kein erkennbarer Einfluss auf die gemessenen Vitalzeichen

15 **Was gehört zur unmittelbaren präoperativen Vorbereitung des Patienten durch die Anästhesiepflege?**

A Ausschließlich das frische Beziehen des Patientenbettes vor dem Eingriff

B Ausschließlich die Information der wartenden Angehörigen über den Ablauf

C Eine gesonderte Vorbereitung des Patienten ist grundsätzlich nicht nötig

D Identität, Nüchternheit und Einwilligung prüfen, Monitoring anlegen, Venenzugang und Medikamente vorbereiten

16 **Welche Maßnahme schützt bei der Narkoseeinleitung am wirksamsten vor Aspiration?**

A Verzicht auf eine Magensonde

B Einhaltung der Nüchternheitsgrenzen und bei Risiko die Ileuseinleitung

C Vertiefung der Sedierung

D Erhöhung der inspiratorischen Sauerstofffraktion

17 **Wozu wird intraoperativ manchmal eine Magensonde gelegt?**

A Zur Sicherung und Aufrechterhaltung der Beatmung über den oberen Atemweg

B Zur kontinuierlichen und exakten Messung des arteriellen Blutdrucks

C Zur Entlastung/Entleerung des Magens (Sekret, Luft) und Verringerung des Aspirations-/Blähungsrisikos

D Zur gezielten und dosierten Zufuhr von Sauerstoff in die Lunge

18 **Wonach wird die Verlegungsfähigkeit aus dem Aufwachraum beurteilt?**

A Ausschließlich nach der aktuellen Uhrzeit im weiteren Tagesverlauf des Patienten

B Ausschließlich nach dem ausdrücklich geäußerten persönlichen Wunsch des Patienten

C Nach stabilen Vitalzeichen, wachem Zustand sowie Schmerz- und Übelkeitskontrolle (z. B. Aldrete-Score)

D Ausschließlich anhand des zuletzt gemessenen Blutzuckerspiegels des Patienten

19 **Welche Maßnahme verhindert eine perioperative Hypothermie?**

A Verzicht auf Abdeckung des Patienten

B Absenken der Raumtemperatur

C Aktive Wärmung mit Wärmedecke und angewärmten Infusionen

D Erhöhung des Frischgasflusses

20 **Wozu dient ein konvektives Patientenwärmesystem (z. B. Warmluftdecke) im OP?**

A Zur maschinellen Beatmung und Sauerstoffversorgung

B Zur fortlaufenden Messung des arteriellen Blutdrucks

C Zur Vorbeugung der perioperativen Auskühlung (Hypothermie)

D Zur exakten Dosierung der verabreichten Narkosegase

21 **Warum ist Temperaturmanagement während einer Narkose wichtig?**

A Weil die Narkose die Wärmeregulation stört und Auskühlung Komplikationen begünstigt

B Weil Wärme grundsätzlich unnötig ist

C Weil die Temperatur keine Rolle spielt

D Weil Kälte die Wundheilung fördert

22 **Welche Parameter überwacht die ATA im Aufwachraum?** ●●

(A) Bewusstsein, Atmung/SpO_2, Kreislauf (RR, Puls), Schmerz, Temperatur, PONV und die OP-/Punktionsstelle

(B) Ausschließlich den vollständigen Namen des betreuten Patienten

(C) Nur die genaue Uhrzeit der Aufnahme in den Aufwachraum

(D) Vorrangig den Zustand und die Sauberkeit der Bettwäsche

23 **Worauf ist beim Transport eines frisch narkotisierten/extubierten Patienten in den Aufwachraum zu achten?** ●●

(A) Auf praktisch gar nichts, da der Transport unkritisch ist

(B) Ausschließlich auf eine möglichst hohe Geschwindigkeit des Transports

(C) Vorrangig auf den Zustand und die Sauberkeit der Bettwäsche

(D) Auf Atmung/Sauerstoffgabe, Überwachung, freie Atemwege und eine strukturierte Übergabe

24 **Worauf achtet die Pflege bei einem liegenden Periduralkatheter (PDK) zur postoperativen Schmerztherapie?** ●●

(A) Ausschließlich auf die pünktliche und vollständige Dokumentation der Uhrzeit

(B) Auf Katheterlage/Verband, Wirkung und Nebenwirkungen (Blutdruck, Motorik/Sensibilität, Harnverhalt) sowie Zeichen einer Infektion

(C) Vor allem auf die korrekte Beschriftung und Sortierung der Bettwäsche des Patienten

(D) Lediglich auf die richtige Angabe der Zimmernummer in der Patientenkurve

3 ATA: Narkose

12 Fragen

25 **Welche Nüchternheitszeiten gelten für elektive Eingriffe üblicherweise bei Erwachsenen?** ●●

(A) Es ist überhaupt keine Nüchternheit vor dem Eingriff erforderlich

(B) Eine strikte Nüchternheit von 24 Stunden für Nahrung und Getränke

(C) Eine kurze Nüchternheit von lediglich etwa 30 Minuten vor der Narkose

(D) Etwa 6 Stunden für feste Nahrung und 2 Stunden für klare Flüssigkeiten

26 **Was bezeichnet „Awareness“ in der Anästhesie?** ●●●

(A) Eine besonders tiefe und sichere Narkose während des Eingriffs

(B) Eine ungewollte Wachheit bzw. Wahrnehmung während der Narkose

(C) Die ausführliche Aufklärung des Patienten vor der Operation

(D) Ein bestimmter Modus der maschinellen Beatmung

27 **Was ist Narkosetiefe und wie wird sie gemessen?** ●●●

(A) Unterdrückung von Schmerz, Stress und Abwehr

(B) Bestimmung per Blutgasanalyse

(C) Subjektiv wie tief der Patient schläft

(D) Anhand der Körpertemperatur

28 **Wann kann ein Patient nach der Narkose meist extubiert werden?** ●●

(A) Unmittelbar und sofort nach dem ersten operativen Hautschnitt

(B) Ausschließlich im Zustand einer noch tiefen Narkose

(C) Wenn er ausreichend wach ist, suffizient spontan atmet und die Schutzreflexe zurück sind

(D) Grundsätzlich und in jedem Fall erst nach Ablauf von 24 Stunden

29 **Was versteht man unter einer balancierten Anästhesie?** ●●

(A) Die Gabe ausschließlich eines einzelnen Schlafmittels

(B) Die Gabe ausschließlich eines einzelnen Schmerzmittels

(C) Eine reine Maskennarkose ganz ohne weitere Medikamente

(D) Die Kombination von Hypnotikum, Analgetikum und ggf. Muskelrelaxans

30 **Was ist die Aufgabe der ATA bei der Assistenz einer Regionalanästhesie (z. B. Spinalanästhesie)?** ●●

(A) Material steril vorbereiten, den Patienten lagern/betreuen und Kreislauf sowie Wirkungseintritt überwachen

(B) Die Punktion zur Regionalanästhesie eigenständig und ohne Beisein eines Arztes durchführen

(C) Während der gesamten Punktion ausschließlich zusehen und keinerlei Aufgaben übernehmen

(D) Den Eingriffsraum während der Anlage der Anästhesie vollständig verlassen

31 **Was ist eine TIVA?** ●●

(A) Eine total intravenöse Anästhesie ohne volatile Narkosegase

(B) Eine reine Regionalanästhesie

(C) Eine Narkose nur mit Lachgas

(D) Eine Anästhesie ohne jede Überwachung

32 **In welchen Bereichen kann eine ATA außerhalb des klassischen OP-Anästhesiebereichs eingesetzt werden?** ●●

(A) In Endoskopie, Ambulanz/Tageschirurgie, Schmerztherapie und Notaufnahme/Schockraum

(B) Ausschließlich im Bereich der reinen Krankenhausverwaltung

(C) Nur im Bereich der Speisenversorgung und Küche der Einrichtung

(D) Ausschließlich in der Bearbeitung von Laborproben im Labor

33 **Was ist Regionalanästhesie?** ●●

(A) Betäubung eines Körperbereichs

(B) Immer mit Vollnarkose

(C) Vollständige Bewusstlosigkeit

(D) Vollnarkose für eine Region

34 **Welche Besonderheit ist bei der Anästhesie von Kleinkindern zu beachten?** ●●●

(A) Sie benötigen während der Narkose grundsätzlich keine Überwachung

(B) Ihr Sauerstoffbedarf ist deutlich geringer als bei Erwachsenen

(C) Sie kühlen im Vergleich zu Erwachsenen deutlich langsamer aus

(D) Sie entsättigen bei Apnoe sehr schnell (geringe Reserve, hoher O_2-Verbrauch) – häufig Maskeneinleitung

35 **Was unterscheidet Spinal- von Periduralanästhesie?**

(A) Bei der Spinalanästhesie wird in den Liquorraum injiziert, bei der Periduralanästhesie in den Periduralraum davor

(B) Beide Verfahren werden gleichermaßen direkt in eine große Vene des Armes gespritzt

(C) Die Spinalanästhesie entfaltet im Unterschied dazu grundsätzlich keinerlei Wirkung

(D) Die Periduralanästhesie betäubt in jedem Fall den gesamten Körper des Patienten

36 **Aus welchen Phasen besteht eine Allgemeinanästhesie grob?**

(A) Nur der Einleitung

(B) Nur der Ausleitung

(C) Einleitung, Aufrechterhaltung und Ausleitung

(D) Ausschließlich der Überwachung

4 ATA: Atemweg

17 Fragen

37 **Warum wird vor der Extubation häufig die Muskelrelaxierung mittels Relaxometrie (TOF) kontrolliert?**

A Um über die zusätzliche Kontrolle die Narkose weiter zu vertiefen

B Um einen gefährlichen Relaxans-Überhang (Restcurarisierung) mit unzureichender Atmung auszuschließen

C Um durch das Weglassen von Zwischenschritten wertvolle Zeit zu sparen

D Um vor der Extubation den aktuellen Blutzuckerwert zu bestimmen

38 **Was ist beim „unerwartet schwierigen Atemweg“ ein zentrales Prinzip des Vorgehens?**

A Möglichst oft dieselbe bereits erfolglose Methode unverändert und wiederholt anwenden

B Möglichst lange allein weiterprobieren, bevor man überhaupt weitere Hilfe hinzuzieht

C Erst ganz am Ende, wenn wirklich nichts mehr hilft, zusätzliche personelle Hilfe rufen

D Nach Algorithmus eskalieren: Oxygenierung sichern, alternative Verfahren (supraglottisch, Videolaryngoskop) und notfalls Front-of-Neck-Access, frühzeitig Hilfe holen

39 **Was ist ein Larynxtubus?**

A Ein zentraler Venenkatheter zur sicheren Gabe von Medikamenten und Infusionen

B Eine spezielle Magensonde zur Entlastung und Ableitung von Magensekret

C Ein transurethraler Blasenkatheter zur kontinuierlichen Ableitung des Harns

D Eine supraglottische Atemwegshilfe, die blind eingeführt wird und mit Cuffs Ösophagus und Rachen abdichtet

40 **Warum wird bei erhöhtem Aspirationsrisiko eine Rapid Sequence Induction (RSI) mit vorbereiteter Absaugung durchgeführt?**

A Vor allem, um bei der Narkoseeinleitung möglichst viel Zeit einzusparen

B Um das Risiko einer Aspiration von Mageninhalt bei der Narkoseeinleitung zu minimieren

C In erster Linie, um teure Narkosemedikamente einsparen zu können

D Hauptsächlich, weil der Ablauf dadurch geordneter und ansprechender wirkt

41 **Was gehört zu den Sofortmaßnahmen bei einer Aspiration während der Narkoseeinleitung?**

A Den Patienten umgehend extubieren und den Tubus vollständig entfernen

B Den Patienten sofort aufsetzen und ihm Wasser zu trinken geben

C Absaugen und ggf. Kopftief-/Seitenlage, Atemweg sichern (Intubation), Beatmung mit Sauerstoff und weitere Therapie

D Zunächst nichts unternehmen und den weiteren Verlauf beobachten

42 **Wozu dient ein Wendl-Tubus (nasopharyngealer Tubus)?** ●●

A Zur Spülung und zur Entlastung des Magens bei akut drohender Aspiration

B Zur kontinuierlichen Messung des arteriellen Blutdrucks über die Nasenhöhle

C Zum Offenhalten der oberen Atemwege über die Nase, auch bei noch teilweise erhaltenen Schutzreflexen

D Zur direkten Messung des Sauerstoffgehalts im Bereich des Nasen-Rachen-Raums

43 **Warum wird vor der Narkoseeinleitung präoxygeniert?** ●●

A Um eine Sauerstoffreserve für die Zeit ohne Beatmung (Apnoe) zu schaffen

B Um den Patienten vor der Narkose gezielt zu erwärmen

C Um dem Auftreten von Übelkeit und Erbrechen vorzubeugen

D Um den arteriellen Blutdruck vor der Narkose zu senken

44 **Wie wird die korrekte Tubuslage unmittelbar nach der Intubation überprüft?** ●●

A Allein durch den direkten Blickkontakt zum freigelegten Operationsgebiet

B Durch Kapnographie ($etCO_2$-Nachweis) plus Auskultation beider Lungen und Beobachtung der Thoraxexkursion

C Ausschließlich durch eine sofortige arterielle Blutgasanalyse im Labor

D Eine gesonderte Überprüfung ist unmittelbar nach der Intubation nicht erforderlich

45 **Wie viel Sauerstoff liefert eine Nasenbrille (Nasenkanüle) grob orientierend?** ●

A Eine niedrige, gut tolerierte Menge (meist 1–6 l/min, ca. 24–40 % FiO_2)

B Grundsätzlich und in jedem Fall reinen Sauerstoff mit 100 Prozent

C Überhaupt keinen zusätzlichen Sauerstoff für den Patienten

D Ausschließlich normale Raumluft ohne jede Anreicherung

46 **Wozu dient ein Guedel-Tubus (oropharyngealer Tubus)?** ●●

A Zur künstlichen Ernährung des Patienten über die Mundhöhle

B Zur kontinuierlichen Messung des arteriellen Blutdrucks

C Zum Absaugen von Urin aus der gefüllten Harnblase

D Zum Freihalten der Atemwege beim Bewusstlosen (verhindert Zurückfallen der Zunge)

47 **Welches Hilfsmittel unterstützt bei einem schwierigen Atemweg?** ●●

A Ein Blutdruckmessgerät

B Ein Blasenkatheter

C Ein Videolaryngoskop

D Ein EKG-Gerät

48 **Wozu dient die Narkosegasabsaugung/-fortleitung (AGFS) im OP?** ●●

A Zur maschinellen Beatmung und Sauerstoffversorgung des Patienten

B Zum Absaugen überschüssiger Narkosegase, um Personal und Umwelt zu schützen

C Zur schnellen Blutstillung im Bereich der Operationswunde

D Zur kontinuierlichen Messung des arteriellen Blutdrucks

49 **Was kennzeichnet die Rapid Sequence Induction (RSI, „Ileuseinleitung“)?** ●●●

A Eine bewusst besonders langsam durchgeführte Narkoseeinleitung

B Eine schnelle Einleitung ohne Zwischenbeatmung zum Schutz vor Aspiration bei Aspirationsgefahr

C Eine Form der Narkose, die ganz ohne Medikamente auskommt

D Eine reine örtliche Betäubung ohne Ausschaltung des Bewusstseins

50 **Was unterscheidet die Larynxmaske vom Endotrachealtubus?** ●●

A Die Larynxmaske wird durch die Stimmritze in die Luftröhre eingeführt

B Die Larynxmaske liegt supraglottisch über dem Kehlkopf, der Tubus in der Luftröhre

C Beide bieten den gleichen Aspirationsschutz

D Der Tubus liegt im Rachen ohne Kontakt zur Luftröhre

51 **Welches Sauerstoff-Applikationssystem liefert (ohne Beatmungsgerät) die höchste inspiratorische Sauerstoffkonzentration?** ●●

A Die Nasenbrille

B Der niedrige Flow einer einfachen Maske

C Ein einfacher Nasenkatheter

D Die Maske mit Reservoirbeutel (Non-Rebreather) bei hohem Flow

52 **Wie hält man die Maske bei der Beutel-Masken-Beatmung dicht?** ●●

A Mit dem C-Griff: Daumen und Zeigefinger auf der Maske, übrige Finger am Unterkiefer

B Die Maske ganz locker und ohne Druck auf das Gesicht auflegen

C Die Maske mit beiden flachen Handflächen fest auf das Gesicht drücken

D Die Maske ganz ohne Kontakt über dem Gesicht schweben lassen

53 **Was ist der Sellick-Handgriff?** ●●●

A Beatmungstechnik

B Halsmassage

C Lagerungshandgriff

D Druck auf Ringknorpel

5 ATA: Monitoring

10 Fragen

54 **Was ist Kapnographie in der Anästhesie?** ●●●

A Herzrhythmusmessung

B Blutdruckmessung

C Messung des CO_2 in der Ausatemluft

D Sauerstoffmessung

55 **Was gehört zum Standard-Monitoring bei einer Allgemeinanästhesie?** ●

A EKG, Blutdruck, Pulsoxymetrie und Kapnographie

B Nur die Körpertemperatur

C Nur der Blutzucker

D Ausschließlich das EKG

56 **Was ist die Aufgabe der ATA bei der Anlage eines zentralen Venenkatheters (ZVK)?** ●●●

A Die Punktion des zentralen Venenkatheters eigenständig und ohne Arzt selbst durchführen

B Steriles Assistieren, Materialvorbereitung, geeignete Lagerung (z. B. Kopftieflage) und Monitoring des Patienten

C Während der gesamten Anlage des Katheters den Eingriffsraum vollständig verlassen

D Die Vorbereitung und Organisation einer nachfolgend geplanten Operation übernehmen

57 **Wo wird intraoperativ bevorzugt die Körperkerntemperatur gemessen?** ●●

A Ausschließlich an der Hautoberfläche im Bereich des Oberarms

B Eine intraoperative Temperaturmessung ist grundsätzlich nicht üblich

C An der Fußsohle des narkotisierten Patienten

D An kernnahen Orten wie Ösophagus, Nasopharynx oder Blase

58 **Was ist beim Anästhesiegeräte-Check zu prüfen?** ●●

A Ausschließlich das EKG und die Sauerstoffsättigung des Patienten

B Vollständig: Dichtigkeit, Gasversorgung, Vaporisator und Monitoring

C Ausschließlich die korrekte und sichere Lagerung des Patienten

D Ausschließlich der noch vorhandene Vorrat an Sauerstoff

59 **Was bereitet die ATA für eine invasive arterielle Blutdruckmessung vor?** ●●

A Ein gespültes Druckmesssystem mit Transducer, Druckbeutel und Monitoranschluss sowie das Punktionsmaterial

B Ausschließlich eine passende Blutdruckmanschette für die nicht-invasive Oberarmmessung

C Eine Magensonde zur Entlastung und zur gezielten Ableitung von Magensekret

D Einen Blasenkatheter zur kontinuierlichen Messung der stündlichen Urinausscheidung

60 **Was ist Pulsoxymetrie?** ●

A Blutdruckmessung

B Atemfrequenz

C Nicht-invasive Messung

D Herzrhythmus

61 **Was ist der Unterschied Respirator vs. Anästhesiegerät?** ●●●

A Beide arbeiten ohne Narkosegas

B Anästhesiegerät nur für Kinder

C Anästhesiegerät mit Vaporisor für Inhalationsgas

D Respirator ist älter

62 **Was kann ein plötzlicher Abfall der $etCO_2$-Kurve (Kapnographie) während der Narkose anzeigen?** ●●●

A Eine Diskonnektion, Tubusdislokation/-verlegung oder einen Kreislaufstillstand

B Eine besonders tiefe Narkose ohne weitere klinische Bedeutung

C Einen deutlich zu hohen Blutzuckerwert des narkotisierten Patienten

D Nichts klinisch Relevantes, das eine Reaktion erfordern würde

63 **Warum stellt die ATA die Alarmgrenzen des Monitorings patientenindividuell ein?** ●●

A Damit die Alarme insgesamt leiser eingestellt sind und den Patienten weniger beim Schlafen stören

B Um durch insgesamt seltenere Alarme den Stromverbrauch des Überwachungsmonitors zu senken

C Damit relevante Abweichungen zuverlässig erkannt werden und keine „Alarmmüdigkeit“ durch Fehlalarme entsteht

D Um die empfindliche Technik des Monitors durch möglichst wenige Auslösungen zu schonen

6 ATA: Medikamente

9 Fragen

64 **Was ist bei einem anaphylaktischen Schock zu tun?** ●●●

A Flach lagern und beobachten

B Abwarten

C Auslöser stoppen

D Patient beruhigen

65 **Warum prüft und ergänzt die ATA regelmäßig den Notfallwagen bzw. die Notfallmedikamente?** ●●

A Damit der Notfallwagen stets aufgeräumt, sauber und ordentlich beschriftet aussieht

B Vorrangig aus langjährig eingeübter Gewohnheit im Rahmen der täglichen Stationsroutine

C Damit im Notfall alle Medikamente und Materialien vollständig, unverfallen und sofort griffbereit sind

D Um im Notfallwagen zusätzlichen freien Platz für weitere Materialien zu schaffen

66 **Warum werden Medikamentenspritzen in der Anästhesie standardisiert farbcodiert beschriftet?** ●●

A Ausschließlich zur ansprechenden Gestaltung des Arbeitsplatzes

B In erster Linie, um bei den Etiketten Kosten einzusparen

C Weil es eine organisatorische Vorgabe der Küche ist

D Zur Vermeidung von Medikamentenverwechslungen (Patientensicherheit)

67 **Was bedeutet PONV in der Anästhesie?** ●●

A Einen speziellen Beatmungsmodus

B Postoperative Übelkeit und Erbrechen

C Einen Blutdruckwert

D Eine Narkoseform

68 **Welche Medikamente werden häufig zur Prophylaxe von postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) eingesetzt?** ●●

A Ausschließlich stark wirksame Schmerzmittel gegen die Übelkeit

B Ondansetron und Dexamethason (ggf. weitere Antiemetika)

C Ausschließlich Antibiotika zur Vorbeugung von Infektionen

D Blutdrucksenkende Medikamente zur Kreislaufstabilisierung

69 **Was ist beim Umgang mit Betäubungsmitteln (BtM) in der Anästhesie zu beachten?** ●●

A Sie können frei zugänglich und offen im Arbeitsraum gelagert werden

B Eine gesonderte Dokumentation der Entnahme ist grundsätzlich nicht nötig

C Nicht verbrauchte Reste werden einfach über den Ausguss entsorgt

D Sichere, verschlossene Aufbewahrung, lückenlose Dokumentation von Entnahme/Verbrauch/Verwurf und Nachweis nach BtMVV

70 **Was ist die maligne Hyperthermie?** ●●●

A Ein harmloser, vorübergehender Anstieg der Körpertemperatur

B Eine allergische Reaktion der Haut auf das Fixierpflaster

C Eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung durch bestimmte Narkosemittel, behandelt mit Dantrolen

D Ein völlig normaler und unauffälliger Verlauf der Narkose

71 **Was bewirkt ein Muskelrelaxans in der Anästhesie?** ●●

A Es vertieft ausschließlich den Schlaf und die Narkosetiefe

B Es erschlafft die Skelettmuskulatur (z. B. für Intubation und OP)

C Es wirkt vorrangig schmerzstillend während der Operation

D Es hebt den arteriellen Blutdruck des Patienten an

72 **Was ist eine gefürchtete Komplikation bei Lokalanästhetika (LAST)?** ●●●

A Ein vorübergehender, harmloser Juckreiz an der Einstichstelle

B Eine leichte, rasch abklingende Rötung im Bereich der Injektion

C Ein deutlich vermehrter Speichelfluss während des Eingriffs

D Eine systemische Intoxikation mit Krampfanfällen und Herzrhythmusstörungen

7 ATA: Patientensicherheit

16 Fragen

73 **Warum achtet das Anästhesieteam bei der OP-Lagerung auf Polsterung und korrekte Position der Extremitäten?** ●●

A Ausschließlich aus optischen und ästhetischen Gründen

B Vor allem, um im Operationssaal Platz einzusparen

C Damit der Patient bequemer liegt und schneller wieder aufwacht

D Zur Vermeidung von Druck-, Nerven- und Lagerungsschäden beim narkotisierten, wehrlosen Patienten

74 **Welche Gefahr entsteht durch eine hohe Sauerstoffkonzentration im OP-Feld?** ●●●

A Verstärkte Blutungsneigung

B Vermehrte Hypothermie

C Erhöhte Infektionsrate

D Erhöhte Brandgefahr bei Nutzung von Elektrochirurgie

75 **Was ist die WHO-Surgical Safety Checklist?** ●●

A Medikamentenliste

B 3-Phasen-Checkliste

C Hygienevorschrift

D Personalplanung

76 **Welches Risiko entsteht bei unzureichender Absaugbereitschaft während der Einleitung?** ●●

A Eine Unterkühlung des Körpers mit sinkender Temperatur

B Aspiration von Sekret oder Mageninhalt

C Eine Überzuckerung mit stark erhöhtem Blutzuckerspiegel

D Ein deutlicher Anstieg des arteriellen Blutdrucks

77 **Was wird im Anästhesieprotokoll dokumentiert?** ●●

A Der Narkoseverlauf: Medikamente/Dosierungen, Vitalparameter, Beatmung, Ein-/Ausfuhr und Besonderheiten mit Zeitangaben

B Ausschließlich der vollständige Name und das genaue Geburtsdatum des Patienten

C Nur das Datum und die voraussichtliche Dauer der durchgeführten Operation

D Vorrangig der Speiseplan und die einzuhaltende Nahrungskarenz des Patienten

78 **Was ist OP-Schutzausrüstung für ATA?** ●

A Keine besondere Ausrüstung

B Mundschutz und Schutzbrille

C Sterile Handschuhe und Kittel

D OP-Kleidung, Bereichsschuhe, Haarschutz und Mund-Nasen-Schutz

79 **Wofür steht das SBAR-Schema bei der Patientenübergabe?** ●●

A Ein bestimmter Modus der maschinellen Beatmung von Patienten

B Situation – Background – Assessment – Recommendation

C Ein Medikament zur Einleitung und Aufrechterhaltung der Narkose

D Eine besondere Lagerungsart des Patienten auf dem OP-Tisch

80 **Welcher Punkt wird im Team-Time-out unmittelbar vor Schnitt zwingend bestätigt?** ●●

A Name des Herstellers der Instrumente

B Voraussichtliche OP-Dauer

C Belegungsplan des Folgetages

D Patientenidentität, Eingriff und Eingriffsseite

81 **Warum wird unmittelbar vor jeder Bluttransfusion ein Bedside-Test durchgeführt?** ●●●

A Zur zusätzlichen Kontrolle des arteriellen Blutdrucks am Patientenbett

B Zur standardisierten Einschätzung der aktuellen Schmerzstärke

C Zur Bestätigung der AB0-Blutgruppe am Patientenbett, um eine Fehltransfusion zu verhindern

D Zur genauen Messung der Körpertemperatur vor der Transfusion

82 **Was ist ASA-Klassifikation?** ●●

A Anästhesie-Sicherheit

B Aseptische Standards

C Perioperative

D Arbeitssicherheit

83 **Was ist die Schleuse im OP-Bereich?** ●●

A Desinfektionskammer

B Hygienetrennbereich

C Aufwachraum

D Sperrgebiet

84 **Was muss bei der AWR-Übergabe dokumentiert werden?** ●●

A Ausschließlich der Name und die Operationsdiagnose

B Es ist keine Dokumentation nötig, eine mündliche Übergabe genügt

C OP-Verlauf, Anästhesieverfahren und verabreichte Medikamente

D Ausschließlich die reine Dauer der durchgeführten Operation

85 **Welche Maßnahme senkt das Risiko einer Medikamentenverwechslung im Anästhesiebereich am stärksten?** ●●

A Standardisierte, farbcodierte Beschriftung aller Spritzen

B Zusätzliches Personal im Saal

C Verzicht auf Vorbereitung im Voraus

D Hellere Beleuchtung im Einleitungsraum

86 **Welche Maßnahme verhindert lagerungsbedingte Nervenschäden?**

(A) Abduktion des Arms über 90 Grad

(B) Straffe Fixierung der Extremitäten

(C) Verzicht auf Umlagerungskontrollen

(D) Physiologische Lagerung mit ausreichender Polsterung

87 **Aus welchen drei Phasen besteht die WHO-Checkliste für sichere Chirurgie?**

(A) Sign-in (vor Narkoseeinleitung), Team-Time-Out (vor dem Schnitt) und Sign-out (vor Verlassen des OP)

(B) Eine einzige abschließende Kontrolle ganz am Ende der Operation

(C) Die drei Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen

(D) Die Schritte Wareneingang, Lagerung und Ausgabe des Materials

88 **Wann sind laut WHO die „5 Momente der Händedesinfektion“ unter anderem durchzuführen?**

(A) Vor Patientenkontakt, vor aseptischer Tätigkeit, nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit der Patientenumgebung

(B) Ausschließlich einmal zu Dienstbeginn und einmal zum Dienstende der Schicht

(C) Nur nach dem Kontakt mit sichtbar verschmutzten Flächen im Patientenzimmer

(D) Lediglich vor dem Verlassen der Station und nach der Pausenzeit im Aufenthaltsraum

8 OTA: Sterilität & Hygiene

17 Fragen

89 **Warum durchlaufen Personal und Material Schleusen zum OP-Bereich?** ●●

(A) Ausschließlich zur Kontrolle des Zutritts zum Operationsbereich

(B) Um durch Umkleiden in Bereichskleidung die Keimeinschleppung zu reduzieren

(C) Aus rein organisatorischen Gründen des Ablaufs

(D) Um bewusst Wartezeiten vor dem Eingriff zu erzeugen

90 **Welche Maßnahme schützt beim Anreichen von Material an das sterile Team?** ●●

(A) Der Springer öffnet die Verpackung so, dass der Inhalt ohne Kontakt entnommen werden kann

(B) Der Springer legt das Material direkt mit der Hand auf den Tisch

(C) Das Material wird über das offene OP-Feld gereicht

(D) Das sterile Team greift in die geöffnete Verpackung

91 **Welche Fläche darf eine steril eingekleidete Person nicht berühren?** ●●

(A) Die eigenen sterilen Handschuhe

(B) Jeden unsterilen Bereich, auch unterhalb der Tischkante

(C) Den sterilen Instrumententisch

(D) Die sterilen Abdecktücher

92 **Wozu dient die sterile Abdeckung des OP-Feldes?** ●

(A) Sie schafft eine sterile Barriere um das Operationsgebiet

(B) Sie hält den Patienten warm

(C) Sie dient nur der Dekoration

(D) Sie ersetzt die Hautdesinfektion

93 **Wie sollte präoperativ eine nötige Haarentfernung im OP-Gebiet erfolgen?** ●●

(A) Durch Nassrasur mit Klinge am Vortag

(B) Durch Kürzen mit einem Clipper möglichst kurz vor der OP

(C) Gar nicht und ohne Dokumentation

(D) Durch Ausreißen der Haare

94 **Was ist bei der Hautdesinfektion des OP-Gebiets besonders wichtig?** ●●

(A) Sofort nach dem Auftragen abdecken

(B) Nur mit Wasser reinigen

(C) Möglichst wenig Desinfektionsmittel verwenden

(D) Die vorgeschriebene Einwirkzeit einhalten und das Feld satt benetzen

95 **Woran erkennt man ein einwandfreies Sterilgut vor dem Öffnen?** ●●

(A) Unbeschädigte, trockene Verpackung mit umgeschlagenem Indikator und gültigem Datum

(B) Am Gewicht des verpackten Instrumentensiebs

(C) An der Dauer der bisherigen Lagerung im Regal

(D) Ausschließlich am aufgedruckten Namen des Herstellers

96 **Warum steht ein moderner OP-Saal meist unter leichtem Überdruck mit gefilterter Luft?**

A Damit weniger Keime aus angrenzenden Bereichen einströmen

B Damit die Türen leichter schließen

C Um Energie zu sparen

D Um die Geräte zu kühlen

97 **Worauf ist bei Lagerung und Umgang mit Sterilgut zu achten?**

A Feuchtigkeit an der äußeren Verpackung ist für die Sterilität des Inhalts vollkommen unproblematisch

B Trocken und staubgeschützt lagern, Verfallsdatum und Verpackungsunversehrtheit prüfen; beschädigte/feuchte Verpackungen gelten als unsteril

C Auch sichtbar beschädigte oder eingerissene Verpackungen können bedenkenlos weiterverwendet werden

D Sterilgut kann problemlos auch dauerhaft im feuchten Nassbereich der Station gelagert werden

98 **Was ist Asepsis vs. Antisepsis?**

A Beide gleich

B Asepsis = Keimfreiheit

C Antisepsis nur Hände

D Asepsis nur Labor

99 **Wie zieht man nach der chirurgischen Händedesinfektion sterile Handschuhe an?**

A Mit bloßen Händen von außen anfassen

B In steriler Technik, ohne die Außenseite mit der bloßen Haut zu berühren

C Erst nach der Operation

D Ohne vorherige Händedesinfektion

100 **Welcher Bereich einer steril eingekleideten Person gilt als NICHT steril?**

A Die Brust

B Die Vorderseite oberhalb der Taille

C Die Unterarme

D Der Rücken und alles unterhalb der Taille

101 **Was unterscheidet die chirurgische von der hygienischen Händedesinfektion?**

A Sie dauert länger und bezieht die Unterarme bis zu den Ellenbogen ein

B Sie ist kürzer als die hygienische

C Sie verwendet nur Wasser

D Sie ist vor einer OP unnötig

102 **Wodurch verliert ein Sterilgut seine Sterilität?**

A Durch Ablage auf dem sterilen Instrumententisch

B Durch Feuchtigkeit oder Beschädigung der Verpackung

C Durch Berührung mit sterilen Handschuhen

D Durch Lagerung im geschlossenen Schrank

103 **Welche Folge hat unsteriles Arbeiten für den Patienten?**

A Erhöhtes Risiko einer postoperativen Wundinfektion
B Gestörte Thermoregulation
C Erhöhtes Blutungsrisiko
D Verlängerte Narkosedauer

104 **Wie ist bei einer Kontamination des sterilen Kittels während der OP zu verfahren?**

A Sofort melden und den betroffenen Bereich beziehungsweise die Kleidung wechseln
B Den Bereich mit einem sterilen Tuch abdecken und weiterarbeiten
C Den Vorgang nach der OP nachtragen
D Den Bereich mit Desinfektionsmittel abwischen

105 **Was ist No-Touch-Technik?**

A Ein festgelegtes Protokoll zur Kommunikation im Team
B Eine schmerzfreie Technik zur Verabreichung von Injektionen
C Steril arbeiten ohne Kontakt zwischen sterilem und unsterilem Bereich
D Ein bestimmtes Verfahren bei der Übergabe von Patienten

9 OTA: Aufbereitung

14 Fragen

106 **Wie werden Medizinprodukte nach dem Anwendungsrisiko eingeteilt (nach Spaulding)?**

A Nach der jeweiligen Farbe des Medizinprodukts
B Nach dem herstellenden Unternehmen des Produkts
C Nach dem Gewicht des einzelnen Medizinprodukts
D In unkritisch, semikritisch und kritisch

107 **Warum ist die Chargen- bzw. Sterilgutdokumentation so wichtig?**

A Vor allem für die Planung der Dienste und Schichten des Personals
B In erster Linie für die Bestellung von Essen und Verbrauchsmaterial
C Zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit, welches sterile Set bei welchem Patienten eingesetzt wurde
D Ausschließlich für die interne statistische Auswertung der Einrichtung

108 **Wie ist mit einem beschädigten Instrument im Sieb zu verfahren?**

A Trotzdem verwenden, wenn es funktionsfähig erscheint
B Vor Ort nachbiegen und weiterverwenden
C Aussortieren, kennzeichnen und der Aufbereitung zur Reparatur zuführen
D Nach der OP unverändert zurückgeben

109 **Was ist ein Vorteil von Einmalinstrumenten?**

A Beliebige Wiederverwendbarkeit nach Desinfektion
B Geringere Materialkosten pro Eingriff
C Keine Aufbereitung nötig und gleichbleibende Qualität
D Höhere Belastbarkeit als Mehrweginstrumente

110 **In welcher Reihenfolge läuft die Instrumentenaufbereitung in der Sterilgutversorgung ab?**

- A Reinigung, Verpackung, Lagerung, Sterilisation
- B Reinigung und Desinfektion, Prüfung und Pflege, Verpackung, Sterilisation, Freigabe
- C Verpackung, Reinigung, Sterilisation, Lagerung
- D Sterilisation, Reinigung, Verpackung, Freigabe

111 **Was ist CSSD und welche Aufgaben hat OTA dort?**

- A Ein OP-Bereich
- B Intensivstation
- C Ambulanz
- D Zentrale

112 **In welcher Reihenfolge werden Medizinprodukte in der Aufbereitung (AEMP/ZSVA) typischerweise bearbeitet?**

- A Zuerst die Sterilisation und erst danach die Reinigung
- B Reinigung/Desinfektion → Prüfung/Pflege → Verpackung → Sterilisation → Freigabe/Dokumentation
- C Ein einfaches Abwischen und die sofortige Wiederverwendung
- D Zuerst die Verpackung und erst danach die Reinigung

113 **Was ist der Unterschied Desinfektion vs. Sterilisation?**

- A Sterilisation weniger effektiv
- B Beide bewirken dasselbe
- C Desinfektion reicht für OP-Instrumente
- D Desinfektion = Keimzahlreduktion, Sterilisation = Keimfreiheit

114 **Wann darf ein steril verpacktes Instrument NICHT mehr verwendet werden?**

- A Wenn das einzelne Instrument ein hohes Eigengewicht aufweist
- B Wenn die äußere Sterilverpackung glänzt und unbeschädigt wirkt
- C Wenn die Verpackung beschädigt oder feucht ist bzw. das Verfallsdatum überschritten ist
- D Niemals, da steril verpacktes Gut unbegrenzt haltbar ist

115 **Was ist Sterilgutaufbereitung?**

- A Ausschließlich das Autoklavieren im Dampfsterilisator
- B Reinigung → Desinfektion → Verpackung → Sterilisation
- C Ausschließlich das gründliche Abwaschen der Instrumente
- D Das einfache Einlegen der Instrumente in heißes Wasser

116 **Wie werden thermostabile chirurgische Instrumente üblicherweise sterilisiert?**

- A Durch feuchte Hitze im Autoklav (Dampfsterilisation, meist 134 °C)
- B Durch Abwischen mit Alkohol
- C Durch Einlegen in kaltes Wasser
- D Durch Trocknen an der Luft

117 **Woran erkennt man vor dem Öffnen eines sterilen Sets, dass es einen Sterilisationsprozess durchlaufen hat?** ●●

A An der Farbe der Verpackung

B Am Farbumschlag des Behandlungsindikators

C Am Gewicht

D Am Hersteller

118 **Bei welcher Temperatur wird üblicherweise im Autoklaven bei Standardinstrumenten sterilisiert?** ●●●

A 100 Grad Celsius

B 80 Grad Celsius

C 134 Grad Celsius

D 180 Grad Celsius

119 **Wie wird gebrauchtes chirurgisches Instrumentarium nach der OP korrekt gehandhabt?** ●●

A Nach der Operation einfach trocken auf dem Beitisch liegen lassen

B Sofort und ungereinigt beim nächsten Eingriff erneut verwenden

C Sicher gesammelt und der Aufbereitung (AEMP/ZSVA) zugeführt, ggf. mit Vorbehandlung gegen Antrocknen

D Zur Entsorgung gemeinsam mit dem normalen Hausmüll geben

10 OTA: Instrumente

21 Fragen

120 **Welches Instrument dient dem Fassen und Halten von Gewebe?**

- A Skalpell
- B Klemme
- C Sauger
- D Wundhaken

121 **Welche Schere wird für die feine Gewebepräparation verwendet?**

- A Verbandschere
- B Metzenbaum-Schere
- C Fadenschere
- D Mayo-Schere

122 **Welches Instrument fixiert die Nadel beim Nähen?**

- A Nadelhalter
- B Sauger
- C Tuchklemme
- D Wundhaken

123 **Welche gehören zu den chirurgischen Grundinstrumenten?**

- A Skalpell, Schere, Pinzette und Klemme
- B Nur das Skalpell
- C Ausschließlich Klemmen
- D Nur der Nadelhalter

124 **Was unterscheidet eine anatomische von einer chirurgischen Pinzette?**

- A Die anatomische Pinzette ist grundsätzlich länger und schmaler als die chirurgische
- B Beide unterscheiden sich ausschließlich durch die Farbe ihres Griffstücks voneinander
- C Die anatomische Pinzette hat geriffelte (zahnlose) Branchen und fasst gewebeschonend, die chirurgische hat Zähnchen für festeren Halt
- D Zwischen beiden Pinzettenarten besteht funktionell und baulich kein Unterschied

125 **Was bedeutet Instrumentieren im OP?**

- A Anästhesiemaschine einrichten
- B Sterile Instrumente während OP
- C Patient lagern
- D Sterilgut aufbereiten

126 **Wozu dient ein Nadelhalter im OP?**

- A Zum Durchtrennen von Gewebe und Nahtmaterial während der Operation
- B Zum sicheren Fassen und Führen der chirurgischen Nadel beim Nähen
- C Zum Absaugen von Blut und Spülflüssigkeit aus dem Operationsgebiet
- D Zum Desinfizieren des Operationsfeldes vor dem Hautschnitt

127 **Wozu dienen Wundhaken (Retraktoren) im OP?**

A Zum sorgfältigen Vernähen der Wundränder am Ende der Operation

B Zum Offenhalten der Wunde und Zurückhalten von Gewebe, um Sicht und Zugang zu schaffen

C Zum kontinuierlichen Absaugen von Blut und Spülflüssigkeit aus dem Situs

D Zur gründlichen Desinfektion des Operationsgebiets vor dem Hautschnitt

128 **Was ist die Hauptaufgabe der instrumentierenden OTA am sterilen Tisch?**

A Wichtige Telefonate für das Operationsteam während des Eingriffs führen

B Die Überwachung der Narkose und der Vitalwerte des Patienten

C Die gründliche Reinigung und Desinfektion des Operationssaals

D Instrumente und Materialien steril vorbereiten, ordnen und dem Operateur gezielt anreichen

129 **Wozu dient der Sauger im Operationsgebiet?**

A Zum Trocknen der Haut des Patienten vor dem Hautschnitt

B Zum Entfernen von Blut und Sekret, um die Sicht im OP-Feld zu erhalten

C Zum Kühlen der während der Operation verwendeten Instrumente

D Zur Sterilisation des Operationsgebiets während des Eingriffs

130 **Welches Instrument dient dem scharfen Durchtrennen von Gewebe?**

A Skalpell

B Nadelhalter

C Klemme

D Sauger

131 **Welches Instrument wird klassisch zur Blutstillung an Gefäßen eingesetzt?**

A Sauger

B Wundspreizer

C Péan- oder Overholt-Klemme

D Chirurgische Pinzette

132 **Was ist die springende OTA?**

A Narkose überwachen

B Instrumentierende OTA

C Unsterile Hilfsaufgaben

D Wunden nähen

133 **Was gehört zur Aufgabe der OTA unmittelbar vor OP-Beginn?**

A Den Patienten sedieren

B Die Narkose einleiten

C Vollständigkeit und Sterilität der Instrumente prüfen

D Die Beatmungsparameter einstellen

134 **Welches Instrument fixiert die sterilen Abdecktücher am Patienten?**

A Tuchklemme

B Sauger

C Wundhaken

D Nadelhalter

135 **Welche Schere eignet sich für die grobe Präparation kräftiger Gewebe?**

A Metzenbaum-Schere
B Mayo-Schere
C Feine Irisschere
D Fadenschere

136 **Wozu dient eine Präparierschere (z. B. Metzenbaum-Schere)?**

A Zum feinen Durchtrennen und Präparieren von Gewebe
B Zum Durchtrennen von Draht
C Zum Schneiden von Verbänden außerhalb des OP
D Zum Öffnen von Verpackungen

137 **Wozu dient eine chirurgische Klemme (z. B. Péan-Klemme)?**

A Zum präzisen Durchtrennen von Nahtmaterial und einzelnen Fäden am Ende der Naht
B Zum Vernähen der Wundränder mit einer fortlaufenden oder einer Einzelknopfnaht
C Zum gründlichen Desinfizieren des Operationsgebiets vor dem eigentlichen Hautschnitt
D Zum Fassen, Halten oder Abklemmen von Gewebe/Gefäßen (z. B. zur Blutstillung)

138 **Was versteht man beim Instrumentieren unter der „Neutralzone“?**

A Ein abgegrenzter Bereich außerhalb des eigentlichen Operationssaals
B Eine Ablage, über die scharfe/spitze Instrumente ohne direkte Hand-zu-Hand-Übergabe weitergereicht werden
C Der Ruhe- und Pausenraum des Operationsteams während des Eingriffs
D Ein steriler Vorratsschrank für zusätzliches Instrumentarium und Material

139 **Welches Instrument dient der Darstellung des Operationsfeldes?**

A Der Sauger zum Absaugen von Blut und Spülflüssigkeit aus dem Situs
B Das Skalpell zum Durchtrennen von Haut und darunterliegendem Gewebe
C Wundhaken beziehungsweise Sperrer
D Der Nadelhalter zum sicheren Führen der Nadel beim Vernähen der Wunde

140 **Warum baut die OTA den Instrumentiertisch geordnet und nach einem System auf?**

A Vor allem, damit der Instrumentiertisch für Fotos ordentlich und aufgeräumt wirkt
B In erster Linie, um die Instrumente schnell fotografisch dokumentieren zu können
C Um jederzeit den Überblick zu behalten, zügig anreichen zu können und die Zählkontrolle zu erleichtern
D Hauptsächlich, um auf dem Tisch möglichst viel Platz einzusparen

11 OTA: OP-Technik

19 Fragen

141 **Wozu dient ein intraoperativer Schnellschnitt (Gefrierschnitt)?** ●●●

(A) Zur endgültigen Abrechnung der Operation mit der Krankenkasse

(B) Zur Reinigung und Aufbereitung der verwendeten Instrumente

(C) Zur Dokumentation der korrekten Lagerung des Patienten

(D) Zur raschen feingeweblichen Beurteilung noch während der OP (z. B. gutartig/bösartig)

142 **Welcher Zugang wird in der Gynäkologie und Geburtshilfe häufig gewählt?** ●●

(A) Pfannenstielschnitt

(B) Thorakotomie

(C) Mediane Laparotomie

(D) Rippenbogenrandschnitt

143 **Welches Instrument dient der Bearbeitung von Knochen in der Endoprothetik?** ●●●

(A) Raspel

(B) Anatomische Pinzette

(C) Sauger

(D) Metzenbaum-Schere

144 **Welche Technik schont bei der Präparation empfindliche Strukturen wie Nerven und Gefäße?** ●●●

(A) Großflächige Koagulation

(B) Scharfe Präparation mit dem Skalpell

(C) Stumpfe Präparation

(D) Zug mit der chirurgischen Pinzette

145 **Was ist Elektrochirurgie (HF-Chirurgie)?** ●●●

(A) Eine gezielte Behandlung mit Kälte im Sinne einer Kryotherapie

(B) Die gewöhnliche Chirurgie mit dem klassischen scharfen Messer

(C) Eine Behandlung von Gewebe mit gebündeltem Laserlicht

(D) Hochfrequenzstrom zum Schneiden und Koagulieren von Gewebe

146 **Worauf achtet man beim Anlegen der Neutralelektrode bei der HF-Chirurgie?** ●●●

(A) Sie kann an einer beliebigen Stelle im Raum abgelegt werden

(B) Sie ist im Grunde überflüssig und kann weggelassen werden

(C) Sie wird direkt auf die frische Operationswunde geklebt

(D) Sie muss großflächig und gut haftend auf gut durchbluteter, muskelreicher Haut sitzen

147 **Was unterscheidet bei der HF-Chirurgie den Schneide- (Cut) vom Koagulationsmodus (Coag)?** ●●

(A) Cut und Coag unterscheiden sich lediglich in der Lautstärke des akustischen Gerätesignals

(B) Cut trennt Gewebe mit kontinuierlichem Strom, Coag stillt Blutungen durch Verschorfung mit moduliertem Strom

(C) Der Unterschied liegt allein in der Farbe des am Gerät angeschlossenen Elektrodenkabels

(D) Zwischen dem Schneide- und dem Koagulationsmodus besteht technisch gesehen kein Unterschied

148 **Welches Verfahren verschließt ein Gefäß rein mechanisch?** ●●

(A) Argon-Plasma-Koagulation

(B) Ultraschalldissektion

(C) Elektrokoagulation

(D) Ligatur

149 **Was ist da Vinci Roboter-OP und OTA-Aufgaben?** ●●●

(A) OTA hat keine Aufgabe

(B) Chirurg steuert Roboterarme

(C) Vollautomatische OP

(D) Allein die Anästhesie ist beteiligt

150 **Was ist der Unterschied zwischen Blutleere und Blutsperre?** ●●●

(A) Bei der Blutleere wird das Blut zuvor ausgewickelt, bei der Blutsperre nur der Zufluss gestoppt

(B) Beide Begriffe bedeuten dasselbe

(C) Blutsperre entfernt das gesamte Blut aus dem Körper

(D) Blutleere stoppt nur den venösen Rückfluss

151 **Was unterscheidet die monopolare von der bipolaren HF-Chirurgie?** ●●●

(A) Beide Verfahren unterscheiden sich lediglich durch den jeweiligen Gerätehersteller

(B) Der einzige Unterschied liegt in der Farbe des verwendeten Anschlusskabels

(C) Bipolar arbeitet grundsätzlich mit deutlich höherer Stromstärke als monopolar

(D) Monopolar fließt der Strom durch den Körper zur Neutralelektrode; bipolar fließt er nur zwischen den beiden Branchen des Instruments

152 **Welches Verfahren stillt Blutungen durch Hitzewirkung?** ●●

(A) Elektrokoagulation

(B) Ligatur

(C) Tamponade

(D) Kompression

153 **Was ist das Pneumoperitoneum bei einer Laparoskopie?** ●●●

(A) Eine akute Erkrankung der Lunge mit eingeschränkter Atemfunktion

(B) Eine bakterielle Entzündung des Bauchfells im Bauchraum

(C) Das gezielte Einbringen von CO_2-Gas in die Bauchhöhle, um einen Arbeitsraum zu schaffen

(D) Ein spezieller Beatmungsmodus während der laufenden Narkose

154 **Was ist ein Tourniquet und wie wird es eingesetzt?** ●●●

- A Druckverband
- B Aufblasbare Manschette
- C Lagerungshilfe
- D Venenabsperrsystem

155 **Was ist Laparoskopie?** ●●

- A Offene Bauchoperation
- B Röntgenuntersuchung
- C Herzoperation
- D Minimalinvasive OP: Trokare

156 **Welches Verfahren beschreibt die Laparoskopie?** ●●

- A Minimalinvasiver Zugang über Trokare mit Kamera und CO_2-Insufflation
- B Endoskopie über natürliche Körperöffnungen
- C Offener Zugang über einen langen Bauchschnitt
- D Röntgengestützte Punktion ohne Hautschnitt

157 **Was ist ein wesentlicher Vorteil minimalinvasiver Verfahren?** ●●

- A Geringere Anforderungen an die Sterilität
- B Kleinere Wunden mit weniger Schmerzen und kürzerer Rekonvaleszenz
- C Verzicht auf Allgemeinanästhesie
- D Grundsätzlich kürzere Operationszeit

158 **Warum wird bei der Elektrochirurgie der entstehende chirurgische Rauch abgesaugt?** ●●

- A Weil er gesundheitsschädliche Partikel und potenziell infektiöse/toxische Bestandteile enthalten kann
- B Ausschließlich wegen des unangenehmen Geruchs im Operationssaal
- C Um den Operationssaal während des Eingriffs gezielt herunterzukühlen
- D Aus rein optischen Gründen zur besseren Sicht auf das Operationsfeld

159 **Welcher Zugang bietet bei Eingriffen an mehreren Bauchorganen die beste Übersicht?** ●●

- A Mediane Laparotomie
- B Thorakotomie
- C Wechselschnitt nach McBurney
- D Pfannenstielschnitt

12 OTA: Naht & Wundverschluss

14 Fragen

160 **Warum werden tiefe Wunden mehrschichtig verschlossen?** ●●●

- A Um Hohlräume zu vermeiden und die Spannung auf die tragenden Schichten zu verteilen
- B Um auf eine Drainage verzichten zu können
- C Um Nahtmaterial einzusparen
- D Um die Operationszeit zu verkürzen

161 **Welches Nahtmaterial ist nicht resorbierbar?** ●●●

A Polydioxanon
B Polypropylen
C Polyglactin
D Poliglecapron

162 **Welche Wundauflage eignet sich für stark sezernierende Wunden?** ●●●

A Hydrogel
B Trockene Gaze
C Alginat
D Semipermeable Folie

163 **Was ist ein Vorteil resorbierbarer Nähte?** ●●

A Höhere Dauerfestigkeit als nicht resorbierbare Fäden
B Kein Fadenzug erforderlich
C Bessere Sichtbarkeit im Gewebe
D Geringeres Infektionsrisiko in jedem Fall

164 **Was unterscheidet resorbierbares von nicht-resorbierbarem Nahtmaterial?** ●●

A Resorbierbares Material ist grundsätzlich deutlich dicker
B Nicht-resorbierbares Material löst sich im Gewebe von selbst auf
C Resorbierbares wird vom Körper abgebaut, nicht-resorbierbares muss ggf. entfernt werden
D Zwischen beiden Nahtmaterialien besteht kein Unterschied

165 **Welche Nahttechnik ist beim Hautverschluss kosmetisch besonders günstig?** ●●

A Einzelknopfnaht
B Rückstichnaht nach Donati
C Intrakutane Naht
D Klammernaht

166 **Was bedeutet die USP-Angabe (z. B. 3-0, 4-0) bei chirurgischem Nahtmaterial?** ●●●

A Die Farbe des Fadens zur besseren Unterscheidung im Operationsgebiet
B Die Länge der zum Faden gehörenden chirurgischen Nadel
C Den jeweiligen Hersteller des verwendeten Nahtmaterials
D Die genormte Fadenstärke – je mehr Nullen, desto dünner der Faden

167 **Welche Wundauflage hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht?** ●●

A Trockene Kompresse
B Saugende Vlieskompresse
C Fixierpflaster
D Hydrogel

168 **Wozu dient eine Redon-Drainage?** ●●

A Zur Sicherung der Beatmung und zur Zufuhr von Sauerstoff über die oberen Atemwege
B Zur künstlichen Ernährung des Patienten über einen direkten Zugang in den Magen
C Zur kontinuierlichen Messung des arteriellen Blutdrucks unmittelbar im Wundgebiet
D Zum Ableiten von Wundsekret/Blut aus dem Wundgebiet über einen Unterdruck (Sog)

169 **Welcher Befund spricht für eine infizierte Operationswunde?** ●●

A Eitriges Sekret mit Rötung, Überwärmung und Schmerz

B Klare, seröse Sekretion in geringer Menge

C Leichte Rötung des Wundrands am ersten Tag

D Gelbliches Fibrin im Granulationsgewebe

170 **Was ist der Unterschied primäre vs. sekundäre Wundheilung?** ●●

A Bei der sekundären Heilung sind die Wundränder sauber vernäht

B Beide Heilungsformen verlaufen völlig gleich und ununterscheidbar

C Die primäre Heilung betrifft ausschließlich sehr tiefe Wunden

D Primär = adaptierte Wundränder, sekundär = offene Granulation

171 **Was unterscheidet eine Einzelknopfnaht von einer fortlaufenden Naht?** ●●

A Die beiden Nahttechniken unterscheiden sich allein durch die Farbe des verwendeten Fadens

B Der einzige Unterschied liegt in der Größe der jeweils verwendeten chirurgischen Nadel

C Bei der Einzelknopfnaht wird jeder Stich einzeln geknotet, bei der fortlaufenden Naht mehrere Stiche in einem Zug mit Endknoten

D Zwischen Einzelknopfnaht und fortlaufender Naht besteht praktisch kein Unterschied

172 **Wie werden Operationswunden nach dem Kontaminationsgrad eingeteilt?** ●●●

A In aseptisch (sauber), sauber-kontaminiert, kontaminiert und septisch (schmutzig)

B Ausschließlich nach ihrer Größe in große und kleine Wunden

C Ausschließlich nach ihrer Lage in obere und untere Wunden

D Operationswunden werden grundsätzlich gar nicht eingeteilt

173 **Welches Nahtmaterial wird vom Körper resorbiert?** ●●

A Stahldraht

B Polypropylen, zum Beispiel Prolene

C Polyamid, zum Beispiel Ethilon

D Polyglactin, zum Beispiel Vicryl

13 OTA: Lagerung

12 Fragen

174 **Welche Lagerung ist bei den meisten Eingriffen im Bauchraum Standard?** ●

A Beach-Chair-Position

B Rückenlage

C Seitenlage

D Bauchlage

175 **Welche Lagerung wird bei Schultereingriffen häufig verwendet?** ●●●

A Steinschnittlage

B Bauchlage

C Flache Rückenlage

D Beach-Chair-Position

176 **Wie beugt man Lagerungsschäden während einer OP vor?**

A Den Patienten während des Eingriffs möglichst hart und ganz ohne Polster lagern

B Bereits sichtbar entstandene Druckstellen bewusst ignorieren und belassen

C Die Arme und Beine in ihren Gelenken deutlich über die Normalstellung hinaus überstrecken

D Polsterung, physiologische Gelenkstellung und Schutz gefährdeter Nerven und Knochenvorsprünge

177 **Welche Lagerung wird für den Zugang zum Hüftgelenk gewählt?**

A Bauchlage

B Rückenlage ohne Hilfsmittel

C Seitenlage

D Steinschnittlage

178 **Wozu dienen Lagerungshilfsmittel wie Gelkissen oder Vakuummatratzen im OP?**

A Zur Sicherung und Aufrechterhaltung der Beatmung während der Narkose

B Zur schnellen und zuverlässigen Blutstillung an der Operationswunde

C Zur Sterilisation der während des Eingriffs eingesetzten Instrumente

D Zur druckentlastenden, stabilen Lagerung des Patienten und zur Vermeidung von Lagerungsschäden

179 **Was sind häufige OP-Lagerungen?**

A Die Rückenlage und die Kopftieflagerung als einzige Formen

B Die Sitzlage und eine frei hängende Lagerung des Patienten

C Ausschließlich eine halbsitzende Lagerung des Oberkörpers

D Rückenlage, Bauchlage, Seitenlage und Steinschnittlage

180 **Warum ist Wärmemanagement (Hypothermieprophylaxe) intraoperativ wichtig?**

A Sie ist ausschließlich eine Frage des Komforts des Patienten

B Das Wärmemanagement ist im Grunde ohne wesentliche Bedeutung

C Auskühlung erhöht Komplikationen wie Wundinfektionen und Gerinnungsstörungen

D Eine Auskühlung beschleunigt die Wundheilung sogar

181 **Welche Komplikation droht bei fehlerhafter Lagerung am häufigsten?**

A Ein fieberhafter Infekt mit erhöhter Körpertemperatur

B Eine deutlich erhöhte Konzentration des Blutzuckers

C Druck- und Dehnungsschäden peripherer Nerven

D Eine verminderte Gerinnungsfähigkeit des Blutes

182 **Welche Maßnahme senkt das Dekubitusrisiko während langer Eingriffe?**

A Feste Unterlagen zur besseren Stabilität

B Ringförmige Hilfsmittel unter der Ferse

C Druckverteilende Auflagen und Freilagerung gefährdeter Stellen

D Massage gefährdeter Hautareale vor der OP

183 **Welches Risiko besteht bei unzureichend gesicherter Lagerung?**

(A) Eine deutlich erhöhte Rate an Wundinfektionen

(B) Eine unnötige Verlängerung der gesamten Narkosezeit

(C) Sturz oder Verrutschen des Patienten bei Tischverstellung

(D) Eine Auskühlung des Patienten mit sinkender Temperatur

184 **Was ist das wichtigste Ziel der Patientenlagerung im OP?**

(A) Möglichst schnelle Positionierung

(B) Einsparung von Lagerungsmaterial

(C) Optimaler Zugang bei größtmöglichem Schutz vor Lagerungsschäden

(D) Bequemlichkeit für das Operationsteam

185 **Welche Maßnahme schützt am wirksamsten vor lagerungsbedingten Nervenschäden?**

(A) Verkürzung der Operationsdauer

(B) Möglichst flache Lagerung ohne Hilfsmittel

(C) Straffe Fixierung aller Extremitäten

(D) Physiologische Gelenkstellung mit gezielter Polsterung der Prädilektionsstellen

14 OTA: Sicherheit im OP

18 Fragen

186 **In welchen Bereichen kann eine OTA außerhalb des klassischen OP-Saals arbeiten?** ●●

(A) In Endoskopie, ambulanter Chirurgie und der Sterilgutaufbereitung (AEMP/ZSVA)

(B) Ausschließlich in der Krankenhausverwaltung und im Büro der Einrichtung

(C) Ausschließlich in der krankenhauseigenen Apotheke bei der Arzneiausgabe

(D) Ausschließlich im Rettungsdienst bei der präklinischen Notfallversorgung

187 **Wozu dient die WHO-Checkliste für sichere Chirurgie (Team-Time-Out)?** ●●

(A) Zur korrekten Abrechnung der durchgeführten Operation

(B) Zur Planung der Dienste und Schichten des OP-Teams

(C) Zur Vermeidung von Fehlern wie Eingriffs- oder Seitenverwechslungen

(D) Zur Bestellung von Instrumenten und Verbrauchsmaterial

188 **Welche Maßnahme reduziert Stress und Fehler im OP-Team am stärksten?** ●●

(A) Verzicht auf Absprachen zur Zeitersparnis

(B) Beschleunigung aller Arbeitsschritte

(C) Erhöhung der Personalzahl im Saal

(D) Klare Rollen- und Aufgabenverteilung mit strukturierter Vorbereitung

189 **Was macht eine wirksame Kommunikation im OP-Team aus?** ●●

(A) Kurze Andeutungen unter erfahrenen Kollegen

(B) Ansagen in den Raum ohne festen Empfänger

(C) Rückfragen erst nach Abschluss des Eingriffs

(D) Klare, direkt adressierte Ansagen mit Rückbestätigung

190 **Was ist Zählkontrolle im OP?** ●●

(A) Personalzählung

(B) Schrittzähler

(C) Medikamentenzählung

(D) Zählen von Instrumenten

191 **Wann erfolgt die Zählkontrolle von Instrumenten, Tupfern und Nadeln?** ●●●

(A) Nur auf Anforderung des Operateurs

(B) Vor Operationsbeginn, vor Verschluss der Körperhöhle und am Ende

(C) Ausschließlich am Ende der Operation

(D) Nur bei langen Eingriffen

192 **Welche Maßnahme verhindert Verwechslungen bei Präparaten und Proben?** ●●●

(A) Sammlung aller Proben in einem Behälter

(B) Zuordnung anhand der Reihenfolge der Entnahme

(C) Eindeutige Beschriftung und Bestätigung im Vier-Augen-Prinzip

(D) Beschriftung erst nach Ende der Operation

193 **Wann wird die perioperative Antibiotikaprophylaxe idealerweise gegeben?** ●●

A Erst nach der Operation
B In der Regel etwa 30–60 Minuten vor dem Hautschnitt
C Nur wenn Fieber auftritt
D Immer erst am Folgetag

194 **Was ist Implantat-Dokumentation und warum wichtig?** ●●●

A Bestellliste
B Patientenausweis
C Eine Krankenhausliste
D Chargen-Nr., Hersteller, Typ

195 **Welche Vorbereitung verhindert Verzögerungen im OP-Ablauf am wirksamsten?** ●●

A Nachforderung von Material während des Eingriffs
B Verzicht auf die Sichtprüfung bei vertrauten Sieben
C Prüfung von Vollständigkeit und Funktion aller Siebe und Geräte vor Beginn
D Verkürzung der Rüstzeit zwischen zwei Eingriffen

196 **Welche Aufgabe hat die springende OTA?** ●

A Die eigenständige Durchführung und Führung der Narkose
B Das sterile Arbeiten und Instrumentieren am Beitisch
C Das Einstellen und Überwachen der maschinellen Beatmung
D Unsteril das sterile Team versorgen, Material anreichen und dokumentieren

197 **Was wird im Team-Time-out unmittelbar vor dem Hautschnitt bestätigt?** ●●

A Der Operationsplan des Folgetages
B Die Anzahl der eingesetzten Instrumente
C Identität des Patienten, geplanter Eingriff und markierte Eingriffsseite
D Voraussichtliche Dauer der Operation

198 **Warum enthalten OP-Kompressen und Bauchtücher einen eingewebten Röntgenkontrastfaden?** ●●

A Damit ein versehentlich im Körper verbliebenes Tuch im Röntgenbild auffindbar ist
B Vor allem, um den Tüchern eine bessere und auffälligere Färbung zu geben
C In erster Linie, um die Tücher während der Operation aufhängen zu können
D Ausschließlich aus Gründen der besseren Reißfestigkeit und Stabilität

199 **Wie geht man mit einem entnommenen Gewebepräparat für die Pathologie um?** ●●

A Es nach der Entnahme umgehend und ersatzlos im Abwurf entsorgen
B Es unbeschriftet und ohne Dokumentation auf dem Beitisch liegen lassen
C Es korrekt beschriftet, dokumentiert und fachgerecht (z. B. in Fixierlösung) an die Pathologie weitergeben
D Es unverpackt und mit bloßen Händen im Saal von Hand zu Hand weitergeben

200 **Wie geht man sicher mit Skalpellklingen um, um Schnitt- und Stichverletzungen zu vermeiden?**

(A) Klingen nur mit einem Instrument (z. B. Klemme) auf-/absetzen und über eine Neutralzone anreichen, nie mit bloßen Fingern

(B) Die Skalpellklingen zügig und routiniert mit den bloßen Fingern auf- und absetzen

(C) Benutzte Klingen offen und ungesichert auf dem Instrumententisch liegen lassen

(D) Instrumente mit aufgesetzter Klinge dem Operateur rasch durch Zuwerfen anreichen

201 **Was prüft die OTA-Abschlussprüfung?**

(A) Eine schriftliche Hausarbeit

(B) Eine reine Instrumentenkunde

(C) Schriftlich, mündlich und praktisch

(D) Nur Theorie

202 **Wann findet das „Sign-out“ der OP-Sicherheitscheckliste statt?**

(A) Vor der Einleitung der Narkose zu Beginn des Eingriffs

(B) Unmittelbar nach dem ersten operativen Hautschnitt

(C) Vor dem Verlassen des OP-Saals (u. a. Zählkontrolle, Präparate, Probleme)

(D) Bereits am Vortag der geplanten Operation

203 **Welche Aufgabe hat die instrumentierende OTA?**

(A) Die Vitalzeichen dokumentieren

(B) Unsteril Material öffnen und anreichen

(C) Die Narkose überwachen

(D) Steril am Tisch arbeiten und Instrumente anreichen

Lösungsschlüssel & Erklärungen

ATA: Beruf & Recht

1 **B** ATA: eigenständige Ausbildung, kein Pflegeexamen nötig. Fachpflege Anästhesie: Weiterbildung für exam. Pflegefachkräfte mit Berufserfahrung.

2 **B** ATA: Patientenbetreuung im gesamten Anästhesiebereich (Schleuse bis AWR), Gerätevorbereitung und -kontrolle, Medikamente/Infusionen vorbereiten, Monitoring, Dokumentation.

3 **A** Die ATA legt EKG-Elektroden, Blutdruckmanschette und Pulsoxymeter an, prüft Alarmgrenzen und meldet Abweichungen unverzüglich.

4 **C** Die ATA hält Tubus verschiedener Größen, Führungsstab, Laryngoskop, Blockerspritze, Absaugung und Alternativen wie die Larynxmaske bereit und assistiert bei der Lagekontrolle.

5 **C** Die ATA überwacht die Vitalparameter, erkennt Komplikationen wie Atemdepression und Nachblutung frühzeitig und dokumentiert den Verlauf.

6 **D** ATA-OTA-APrV: 50% gemeinsamer Theorieunterricht – effizient bei gleichzeitiger Spezialisierung.

7 **B** Bei Endoskopien in Sedierung (z. B. mit Propofol) überwacht die ATA Atmung, SpO_2, Kreislauf und Sedierungstiefe, hält Sauerstoff/Absaugung und Notfallausrüstung bereit und erkennt frühzeitig Komplikationen (Atemdepression, Aspiration).

8 **C** Im Schockraum unterstützt die ATA das Team bei Atemwegssicherung (Intubation), Beatmung, Kreislaufmanagement und Medikamentengabe und überwacht die Vitalfunktionen des kritisch kranken/verletzten Patienten – Teil der strukturierten Schockraumversorgung.

9 **D** ATA-OTA-Gesetz in Kraft seit 01.01.2022. Davor nur DKG-Empfehlung – kein staatl. anerkannter Abschluss.

10 **A** Die ATA betreut den Patienten von der Schleuse bis zum Aufwachraum, bereitet Geräte und Medikamente vor und assistiert bei Einleitung, Aufrechterhaltung und Ausleitung.

11 **B** ATA-Abschlussprüfung (ATA-OTA-APrV): Schriftlich, Mündlich, Praktisch. Alle 3 Teile müssen mindestens 'ausreichend' sein. Zuständig: Bezirksregierungen NRW.

12 **C** ATA-OTA-G: Bundesgesetz vom 14.12.2019, in Kraft 01.01.2022. Regelt Berufsbezeichnung, Ausbildungsdauer, Prüfung, Berufsausübung.

13 **B** Vor jeder Narkose werden Narkosegerät, Absaugung, Monitoring, Beatmungsbeutel, Atemwegsmaterial und Notfallmedikamente geprüft und bereitgelegt.

ATA: Perioperative Versorgung

14 **C** Ein bedeutsamer Blutverlust zeigt sich durch Blutdruckabfall, Tachykardie, Blässe, verlängerte Rekapillarisierungszeit und abnehmende Urinausscheidung. Die ATA überwacht die Vitalzeichen, schätzt den Verlust (Sauger, Tücher) mit ein und bereitet Volumen-/Blutgabe vor.

15 **D** Vor der Narkose werden u. a. Patientenidentität, Nüchternheit, Einwilligung und Allergien geprüft (Team-Time-Out/WHO-Checkliste), Monitoring (EKG, SpO_2, RR) angelegt, ein venöser Zugang gelegt und die benötigten Medikamente vorbereitet.

16 **B** Als Nüchternheitsgrenzen gelten 6 Stunden für feste Nahrung und 2 Stunden für klare Flüssigkeiten. Beim nicht nüchternen Patienten erfolgt die Rapid Sequence Induction.

17 **C** Eine intraoperativ gelegte Magensonde entlastet den Magen von Sekret und Luft (z. B. nach Maskenbeatmung), verringert Aspirations- und Blähungsrisiko und verbessert bei manchen Eingriffen die Übersicht. Lagekontrolle und Fixierung sind wichtig.

18 **C** Die Entlassung aus dem Aufwachraum richtet sich nach Kriterien wie stabilen Vitalparametern, ausreichender Vigilanz, Atmung, Kreislauf, kontrollierten Schmerzen und Übelkeit – strukturiert z. B. über den Aldrete-Score.

19 **C** Schon eine leichte Hypothermie erhöht Wundinfektionsrate, Blutverlust und Shivering. Die Wärmung beginnt bereits präoperativ.

20 **C** Konvektive Wärmesysteme (Warmluftdecken) halten die Körpertemperatur während der OP stabil und beugen einer perioperativen Hypothermie vor – diese erhöht sonst u. a. Gerinnungs-, Infektions- und Herzrisiken.

21 **A** In Narkose ist die körpereigene Wärmeregulation beeinträchtigt, sodass Patienten leicht auskühlen. Eine Hypothermie erhöht u. a. Wundinfektions-, Gerinnungs- und Herz-Kreislauf-Risiken. Wärmedecken, angewärmte Infusionen und Temperaturmonitoring beugen vor.

22 **A** Im Aufwachraum werden u. a. Bewusstsein, Atmung und SpO_2, Kreislauf (Blutdruck, Puls, EKG), Schmerz, Körpertemperatur, Übelkeit/Erbrechen (PONV) sowie Wund-/Punktionsstellen überwacht – bis die Verlegungskriterien (z. B. Aldrete-Score) erfüllt sind.

23 **D** Beim Transport in den AWR werden Atmung und Bewusstsein überwacht, bei Bedarf Sauerstoff gegeben, die Atemwege freigehalten (Cave Verlegung/Nachbeatmung) und eine strukturierte Übergabe (z. B. SBAR) an das AWR-Personal gegeben.

24 **B** Beim PDK werden Katheterlage und Einstichstelle (Verband, Infektionszeichen), die analgetische Wirkung und Nebenwirkungen überwacht: Blutdruckabfall, motorische/sensorische Blockade, Harnverhalt und selten neurologische Komplikationen. Die Dosierung erfolgt nach ärztlicher Anordnung, oft per Pumpe.

ATA: Narkose

25 **D** Zur Aspirationsprophylaxe gelten bei elektiven Eingriffen meist ca. 6 Stunden Karenz für feste Nahrung und 2 Stunden für klare Flüssigkeiten (Details je nach Klinikstandard). Die ATA prüft und dokumentiert die Nüchternheit.

26 **B** Awareness ist die seltene, ungewollte intraoperative Wachheit mit Wahrnehmung von Ereignissen während der Allgemeinanästhesie. Ausreichende Narkosetiefe, Monitoring und sorgfältige Medikamentengabe beugen vor; Betroffene brauchen Nachbetreuung.

27 **A** Narkosetiefe: klinische Zeichen (RR, HF, Schwitzen) + BIS-Monitor (EEG-basiert, Ziel 40-60). Zu flach → Awareness. Zu tief → Überdosierung.

28 **C** Vor der Extubation müssen ausreichende Spontanatmung, Schutzreflexe (Schlucken/Husten), stabile Vitalzeichen und ein wacher Zustand vorliegen; die Muskelrelaxierung muss abgeklungen sein. Absaugbereitschaft und Reintubationsmaterial liegen bereit.

29 **D** Bei der balancierten Anästhesie werden mehrere Komponenten kombiniert: ein Hypnotikum (Schlaf, oft volatiles Anästhetikum), ein Analgetikum (Schmerzfreiheit, z. B. Opioid) und bei Bedarf ein Muskelrelaxans. So lässt sich jede Komponente gezielt steuern.

30 **A** Bei der Regionalanästhesie assistiert die ATA: steriles Vorbereiten des Materials, korrekte Lagerung (z. B. sitzend/„Katzenbuckel“), Patientenbetreuung, Monitoring und Beobachtung von Wirkungseintritt und Kreislauf (Cave Blutdruckabfall bei Spinalanästhesie).

31 **A** Bei der totalen intravenösen Anästhesie (TIVA) werden alle Narkosekomponenten über die Vene zugeführt (z. B. Propofol plus Opioid, oft per Perfusor/TCI), ohne volatile Narkosegase. Sie senkt u. a. das PONV-Risiko.

32 **A** ATA arbeiten nicht nur im OP-Anästhesiebereich, sondern u. a. in Endoskopieabteilungen, ambulanten OP-/Tageskliniken, der Schmerztherapie, in der Notaufnahme/im Schockraum und im Aufwachraum – überall dort, wo Anästhesie/Sedierung und Überwachung nötig sind.

33 **A** Regionalanästhesie: Spinal, Epidural, Plexus-Blockaden. Vorteile: Patient wach, weniger PONV, bessere postop. Analgesie, frühere Mobilisation.

34 **D** Kinder haben eine geringe funktionelle Residualkapazität und einen hohen Sauerstoffverbrauch – bei Apnoe fällt die Sättigung sehr rasch. Häufig erfolgt eine Maskeneinleitung mit volatilen Anästhetika; Wärmeschutz, gewichtsadaptierte Dosierung und passendes Equipment sind essenziell.

35 **A** Bei der Spinalanästhesie wird das Lokalanästhetikum in den Subarachnoidalraum (Liquor) gespritzt – rascher Wirkeintritt, kleine Menge. Bei der Periduralanästhesie liegt der Katheter im Periduralraum davor – langsamer, steuerbar, auch zur postoperativen Analgesie.

36 **C** Eine Allgemeinanästhesie gliedert sich in Einleitung (Bewusstseinsverlust, Atemwegssicherung), Aufrechterhaltung (Narkose während der OP) und Ausleitung (Beenden der Narkotika, Extubation). Die ATA assistiert in allen Phasen.

ATA: Atemweg

37 **B** Ein Relaxans-Überhang (Restcurarisierung) kann nach der Extubation zu unzureichender Atmung, Schluckstörung und Aspiration führen. Die Relaxometrie (Train-of-Four) prüft die neuromuskuläre Erholung; bei Bedarf wird mit Sugammadex oder Neostigmin antagonisiert.

38 **D** Bei schwierigem Atemweg gilt: Oxygenierung hat Priorität, frühzeitig Hilfe holen und nach Algorithmus (z. B. DGAI/DAS) eskalieren – Maskenbeatmung, supraglottische Atemwegshilfe, Videolaryngoskopie und als Ultima Ratio der invasive Front-of-Neck-Access (Koniotomie). Wiederholte frustrane Intubationsversuche sind zu vermeiden.

39 **D** Der Larynxtubus ist eine supraglottische Atemwegshilfe (ähnlich der Larynxmaske). Er wird blind eingeführt, dichtet mit zwei Cuffs Ösophagus und Rachen ab und ermöglicht die Beatmung – häufig als Alternative/Notfalloption im Atemwegsmanagement.

40 **B** Bei nicht-nüchternen oder aspirationsgefährdeten Patienten wird per RSI rasch eingeleitet und intubiert (Präoxygenierung, schnell wirksames Hypnotikum + Relaxans, ggf. Krikoiddruck), um die Zeit ohne gesicherten Atemweg kurz zu halten. Eine funktionsbereite Absaugung ist Pflicht.

41 **C** Bei Aspiration: rasches Absaugen des Rachens, ggf. Kopftief-/Seitenlage, umgehende Atemwegssicherung (Intubation) und Beatmung mit Sauerstoff, danach ggf. bronchiale Absaugung und weitere Behandlung. Die RSI dient gerade der Vermeidung dieses Ereignisses.

42 **C** Der Wendl-Tubus wird über die Nase in den Rachen eingeführt und hält bei (teilweise) erhaltenen Reflexen die oberen Atemwege frei – er wird oft besser toleriert als der Guedel-Tubus. Cave: Kontraindikation bei Verdacht auf Schädelbasisfraktur.

43 **A** Bei der Präoxygenierung atmet der Patient vor der Einleitung einige Minuten Sauerstoff, um die funktionelle Residualkapazität mit O2 aufzufüllen (Denitrogenisierung). So bleibt während der Apnoephase bis zur Intubation mehr Zeit, bevor die Sättigung abfällt.

44 **B** Der sicherste Nachweis der endotrachealen Lage ist die anhaltende $etCO_2$-Kurve (Kapnographie). Ergänzend: seitengleiche Auskultation beider Lungen und über dem Magen sowie symmetrische Thoraxexkursion. So werden ösophageale oder einseitige Fehllagen erkannt.

45 **A** Die Nasenbrille liefert niedrige Flussraten (meist 1–6 l/min), was etwa 24–40 % FiO_2 entspricht. Sie ist bequem und für die Basis-Sauerstoffgabe geeignet; bei höherem Bedarf werden Maskensysteme verwendet.

46 **D** Der Guedel-Tubus wird über den Mund in den Rachen eingelegt und verhindert beim bewusstlosen Patienten das Zurückfallen der Zunge, sodass die oberen Atemwege frei bleiben. Bei erhaltenen Schutzreflexen kann er Würgereiz auslösen.

47 **C** Bei schwierigem Atemweg helfen u. a. Videolaryngoskop, Führungsstab/Bougie, alternative Larynxmasken und ein bereitliegender Notfallalgorithmus. Die ATA hält das Equipment für den schwierigen Atemweg bereit und assistiert strukturiert.

48 **B** Die Narkosegasfortleitung/-absaugung (AGFS) entfernt überschüssige Anästhesiegase aus dem OP, um die chronische Belastung des Personals und die Umwelt zu reduzieren. Eine regelmäßige Funktionskontrolle ist Teil des Gerätechecks.

49 **B** Die RSI dient dem Schutz vor Aspiration bei nicht nüchternen oder gefährdeten Patienten: rasche Gabe von Hypnotikum und schnell wirksamem Relaxans, möglichst ohne Zwischenbeatmung, oft mit Krikoiddruck, und zügige Intubation.

50 **B** Die Larynxmaske ist ein supraglottischer Atemweg, der über dem Kehlkopfeingang abdichtet. Der Endotrachealtubus liegt in der Trachea und bietet einen besseren Aspirationsschutz, ist aber invasiver. Die Wahl hängt von Eingriff und Risiko ab.

51 **D** Eine Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel (Non-Rebreather) liefert bei ausreichend hohem Flow die höchste O_2-Konzentration (bis ca. 85–95 %). Nasenbrille und einfache Maske erreichen deutlich niedrigere Werte. Bei Hypoxie ist das Reservoirsystem Mittel der Wahl.

52 **A** Beim C-Griff bilden Daumen und Zeigefinger ein „C“ auf der Maske, während die übrigen Finger den Unterkiefer anheben (Esmarch-Handgriff). So wird die Maske abgedichtet und der Atemweg offen gehalten.

53 **D** Sellick: gezielter Krikoiddruck → Ösophagus-Kompression → verhindert passive Regurgitation. Kontrovers: kann Intubation erschweren. Nur auf Anweisung des Anästhesisten!

ATA: Monitoring

54 **C** Kapnographie: etCO_2-Messung. Normwert 35-45 mmHg. Wichtigster Parameter zur Bestätigung korrekter Tubuslage (Kapnographiekurve). Zu hoch → Hypoventilation, zu niedrig → Hyperventilation/Kreislaufproblem.

55 **A** Zum anästhesiologischen Basismonitoring gehören EKG, (nicht-)invasive Blutdruckmessung, Pulsoxymetrie (SpO2) und bei Beatmung die Kapnographie (etCO2); je nach Eingriff kommen Temperatur, Relaxometrie und erweitertes Monitoring hinzu.

56 **B** Bei der ZVK-Anlage assistiert die ATA steril, bereitet das Set vor, lagert den Patienten geeignet (oft leichte Kopftieflage/Trendelenburg zur Venenfüllung und Luftembolieprophylaxe), überwacht Monitoring/EKG (Rhythmusstörungen bei Drahtvorschub) und achtet auf Komplikationen (z. B. Pneumothorax).

57 **D** Zur Überwachung der perioperativen Hypothermie wird die Körperkerntemperatur an kernnahen Messorten erfasst – z. B. ösophageal, nasopharyngeal, im Blasenkatheter oder tympanal. Oberflächenmessungen unterschätzen die Kerntemperatur.

58 **B** Täglicher Gerätecheck: Dichtigkeit Atemkreis, Gasversorgung O_2/Luft, Vaporisatorfüllung, Kapnographie, Absauger, Monitoring-Kabel, Notfallmedikamente griffbereit, Intubationsset komplett. Dokumentation Pflicht!

59 **A** Für die invasive Messung richtet die ATA ein entlüftetes/gespültes Druckmesssystem mit Transducer, Druckbeutel (~300 mmHg) und Monitorkabel sowie das sterile Punktionsmaterial. Nach der Anlage werden Nullabgleich und Transducer-Höhe (Herzhöhe) kontrolliert.

60 **C** Pulsoxymetrie: SpO_2 mittels rot/infrarot. Normwert ≥95%. Limitierungen: Nagellack, Kreislaufstörungen, CO-Vergiftung. Immer mit klinischem Bild kombinieren!

61 **C** Anästhesiegerät: Vaporisor, Kreissystem mit CO_2-Absorber. Respirator: mehr Beatmungsmodi, genauere Lungenmechanik-Überwachung, kein Vaporisor.

62 **A** Ein plötzlicher etCO_2-Abfall ist ein Alarmzeichen: mögliche Ursachen sind Diskonnektion des Beatmungssystems, Tubusdislokation oder -verlegung, aber auch ein drastischer Abfall des Herzzeitvolumens bis zum Kreislaufstillstand. Sofortige Kontrolle von Tubus, System und Kreislauf.

63 **C** Sinnvoll gesetzte, patientenindividuelle Alarmgrenzen sorgen dafür, dass echte Verschlechterungen zuverlässig gemeldet werden, ohne dass ständige Fehlalarme zu „Alarmmüdigkeit“ führen. Alarme dürfen nie dauerhaft deaktiviert werden.

ATA: Medikamente

64 **C** Anaphylaxie: auslösendes Mittel sofort stoppen, Adrenalin 0,01mg/kg i.v. oder 0,5mg i.m., 100% O_2, 500-1000ml Volumenbolus, H1/H2-Antihistaminika, Kortison. ATA bereitet Medikamente vor.

65 **C** Im Anästhesie-/Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb werden Notfallwagen, Notfallmedikamente (z. B. Adrenalin, Atropin), Intubationszubehör und Defibrillator regelmäßig auf Vollständigkeit, Funktion und Verfallsdatum geprüft und dokumentiert.

66 **D** Anästhesie-Spritzen werden nach standardisiertem Farbcode (ISO/DIVI) und mit Klartext beschriftet, um lebensgefährliche Verwechslungen zwischen Medikamentengruppen (z. B. Relaxans, Opioid, Katecholamin) zu vermeiden. Das ist ein zentrales Element der Medikamentensicherheit.

67 **B** PONV steht für „postoperative nausea and vomiting“ (postoperative Übelkeit und Erbrechen). Risikofaktoren werden erfasst (z. B. Apfel-Score) und prophylaktisch behandelt (z. B. Antiemetika, TIVA statt volatiler Gase).

68 **B** Zur PONV-Prophylaxe werden u. a. Ondansetron (5-HT_3-Antagonist), Dexamethason und weitere Antiemetika kombiniert – je nach Risikoscore (z. B. Apfel-Score). Auch eine TIVA mit Propofol senkt das PONV-Risiko.

69 **D** Betäubungsmittel (z. B. Opioide) unterliegen der BtMVV: sichere, verschlossene Aufbewahrung, lückenlose Dokumentation von Zugang, Verbrauch und Verwurf (mit Zeugen) sowie regelmäßige Bestandskontrolle. Fehlmengen müssen aufgeklärt werden.

70 **C** Die maligne Hyperthermie ist eine seltene, lebensbedrohliche Reaktion (v. a. auf volatile Anästhetika und Succinylcholin) mit Hypermetabolismus, Temperaturanstieg und Muskelrigidität. Therapie: Trigger stoppen, Dantrolen geben, kühlen – das Notfallset muss verfügbar sein.

71 **B** Muskelrelaxanzien erschlaffen die Skelettmuskulatur und erleichtern Intubation und operativen Zugang. Ihre Wirkung kann antagonisiert werden (z. B. Sugammadex bei Rocuronium); eine Relaxometrie überwacht den Grad der Blockade.

72 **D** Die systemische Lokalanästhetika-Intoxikation (LAST) entsteht durch zu hohe Blutspiegel (z. B. versehentliche intravasale Injektion) und äußert sich in neurologischen (Krämpfe) und kardialen Symptomen bis zum Kreislaufstillstand. Therapie: Zufuhr stoppen, Basismaßnahmen, Lipidemulsion.

ATA: Patientensicherheit

73 **D** Der narkotisierte Patient kann Fehllagen nicht bemerken oder korrigieren. Sorgfältige Polsterung und physiologische Positionierung (z. B. Arme unter 90° abduziert) beugen Druckstellen, Nervenschäden (z. B. Plexus, N. ulnaris) und weiteren Lagerungsschäden vor – gemeinsame Verantwortung von Anästhesie und OP-Team.

74 **D** Sauerstoff wirkt brandfördernd. Bei Eingriffen im Kopf-Hals-Bereich wird die Konzentration reduziert und der Sauerstoff unter der Abdeckung abgeleitet.

75 **B** WHO-Checklist: Sign-in (Identität, Allergien, Nüchternheit), Time-out (Team, OP-Stelle, Antibiotika), Sign-out (Instrumentenzählung, Diagnose, AWR-Aufklärung). Reduziert Komplikationen signifikant.

76 **B** Eine funktionsbereite Absaugung gehört zur Grundausstattung jedes Anästhesiearbeitsplatzes und wird vor jeder Einleitung geprüft.

77 **A** Das (meist digitale) Anästhesieprotokoll dokumentiert lückenlos den Narkoseverlauf: verabreichte Medikamente mit Dosis und Zeit, kontinuierliche Vitalparameter, Beatmungseinstellungen, Flüssigkeits-/Blutgabe, Zwischenfälle und die Übergabe – rechtlich und medizinisch wichtig.

78 **D** OP-Grundausstattung: OP-Kleidung (Hose + Kasack), Bereichsschuhe, Haarschutz (alle Haare bedeckt), MNS. Bei Körperflüssigkeitskontakt: Schutzbrille. Steril: Kittel + Handschuhe.

79 **B** SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) strukturiert die Übergabe: aktuelle Situation, Vorgeschichte, Einschätzung und Empfehlung/nächste Schritte. Es reduziert Kommunikationsfehler – z. B. bei der Übergabe in den Aufwachraum.

80 **D** Das Team-Time-out nach der WHO-Checkliste findet bei Anwesenheit aller Beteiligten statt und verhindert Eingriffs- und Seitenverwechslungen.

81 **C** Der Bedside-Test (AB0-Identitätstest) wird direkt am Patientenbett unter ärztlicher Verantwortung durchgeführt und bestätigt die AB0-Blutgruppe des Empfängers. Er ist die letzte Sicherheitsbarriere gegen eine lebensgefährliche AB0-Fehltransfusion.

82 **C** ASA: I=gesund, II=leichte Erkrankung, III=schwere Erkrankung, IV=lebensbedrohlich, V=moribund, VI=Hirntod. Beeinflusst Narkosevorbereitung und Risikomanagement.

83 **B** Schleuse: Hygienebarriere. Personalschleuse: Umkleiden, Händedesinfektion, Bereichskleidung. Patientenschleuse: Umlagerung auf OP-Tisch, Bettenkontrolle.

84 **C** Strukturierte Übergabe: Patientenidentifikation, OP-Diagnose, Anästhesieverfahren, Medikamente (Analgetika, Antiemetika), Vitalwerte, Schmerzscore (NRS), Übelkeit, Drainagen, Infusionen.

85 **A** Spritzen werden unmittelbar nach dem Aufziehen nach ISO-Standard beschriftet. Ergänzend gilt das Vier-Augen-Prinzip bei Hochrisikomedikamenten.

86 **D** Besonders gefährdet sind Plexus brachialis, N. ulnaris und N. peroneus. Der Arm wird maximal 90 Grad abduziert, Druckstellen werden gepolstert.

87 **A** Die WHO-Checkliste hat drei Phasen: Sign-in (vor Narkoseeinleitung: Identität, Eingriff, Allergien …), Team-Time-Out (vor dem Hautschnitt: Team, Eingriff, Antibiotikaprophylaxe …) und Sign-out (vor Verlassen des Saals: Zählkontrolle, Präparate …). Sie senkt Komplikationen nachweislich.

88 **A** Die „5 Momente“ der WHO: (1) vor Patientenkontakt, (2) vor aseptischer Tätigkeit, (3) nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, (4) nach Patientenkontakt, (5) nach Kontakt mit der Patientenumgebung. Sie sind Kern der Infektionsprävention.

OTA: Sterilität & Hygiene

89 **B** Über Personal- und Materialschleusen wird beim Wechsel in den OP-Bereich Bereichskleidung (inklusive Haube und Mund-Nasen-Schutz) angelegt bzw. Material umgesetzt. So wird das Einschleppen von Keimen aus dem Außenbereich reduziert.

90 **A** Der unsterile Springer öffnet die Peel-Verpackung nach außen. Die sterile Person entnimmt den Inhalt, ohne die Außenseite zu berühren, und nichts wird über dem OP-Feld gereicht.

91 **B** Steril ist die Vorderseite vom Brustbereich bis zur Tischkante und die Arme bis zum Ellenbogen. Alles unterhalb der Tischebene und der Rücken gelten als unsteril.

92 **A** Die sterile Abdeckung (Lochtuch/Abdecksystem) schafft eine sterile Arbeitszone rund um das freigelegte, desinfizierte OP-Feld und trennt es vom unsterilen Umfeld. Sie ersetzt aber nicht die vorherige Hautdesinfektion.

93 **B** Wenn eine Haarentfernung nötig ist, wird sie möglichst kurz vor dem Eingriff und schonend mit einem Clipper (Kürzen) durchgeführt. Eine Nassrasur mit Klinge verursacht Mikroverletzungen und erhöht das Wundinfektionsrisiko.

94 **D** Die Hautdesinfektion muss das OP-Gebiet satt benetzen und die herstellerabhängige Einwirkzeit vollständig einhalten (bei talgdrüsenreicher Haut länger). Erst danach wird steril abgedeckt – sonst ist die Keimreduktion unzureichend.

95 **A** Geprüft werden Unversehrtheit, Trockenheit, Verfallsdatum und der Behandlungsindikator. Der Indikator belegt nur die Durchführung, nicht die erfolgreiche Sterilisation.

96 **A** Leichter Überdruck und (teils laminare) gefilterte Luftströmung sorgen dafür, dass Luft aus dem reinen OP-Bereich nach außen strömt und weniger Keime aus angrenzenden, weniger reinen Zonen eindringen – Teil des Infektionsschutzkonzepts.

97 **B** Sterilgut wird trocken, staubgeschützt und sachgerecht gelagert. Vor Gebrauch werden Verfallsdatum, Sterilisationsindikator und Verpackungsunversehrtheit geprüft. Beschädigte, feuchte oder abgelaufene Verpackungen gelten als unsteril und dürfen nicht verwendet werden.

98 **B** Asepsis: sterile Instrumente, steriler Kittel/Handschuhe, No-Touch. Antisepsis: Hautdesinfektion (Hautantiseptikum), Wunddesinfektion (Schleimhautantiseptikum).

99 **B** Sterile Handschuhe werden in steriler Technik angezogen: Die Außenfläche darf nicht mit der bloßen Haut berührt werden. Häufig wird die geschlossene Anziehtechnik über den sterilen Kittel genutzt, um die Sterilität zu wahren.

100 **D** Als steril gelten bei korrekt eingekleidetem Personal die Vorderseite vom Brustbereich bis Taillenhöhe und die Unterarme. Der Rücken, Bereiche unterhalb der Taille und oberhalb der Schultern gelten als unsteril und dürfen das sterile Feld nicht berühren.

101 **A** Die chirurgische Händedesinfektion vor einem Eingriff dauert länger (mehrere Minuten je nach Präparat), erfasst Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen und reduziert auch Teile der residenten Hautflora.

102 **B** Feuchtigkeit macht die Verpackung keimdurchlässig. Ebenso unsteril sind Sterilgüter mit Riss, offener Siegelnaht oder überschrittenem Verfallsdatum.

103 **A** Erreger gelangen direkt in die Wunde. Postoperative Wundinfektionen zählen zu den häufigsten nosokomialen Infektionen und verlängern die Verweildauer erheblich.

104 **A** Kontamination wird unverzüglich offen kommuniziert. Fehlerkultur schützt den Patienten, Verschweigen erhöht das Risiko einer Wundinfektion.

105 **C** No-Touch: Grundprinzip der Asepsis. Kein Kontakt steril/unsteril. Bei Verletzung sofortiger Austausch des kontaminierten Materials.

OTA: Aufbereitung

106 **D** Nach Spaulding werden Medizinprodukte je nach Anwendung in unkritisch (intakte Haut), semikritisch (Schleimhaut) und kritisch (Durchdringung von Haut/Schleimhaut, steriles Gewebe) eingeteilt – daraus ergeben sich die Anforderungen an die Aufbereitung.

107 **C** Über die Chargendokumentation lässt sich nachvollziehen, welches sterilisierte Set (mit Sterilisationscharge) bei welchem Patienten verwendet wurde. Das ermöglicht im Problemfall (z. B. Sterilisationsfehler) gezieltes Rückverfolgen – rechtlich und hygienisch essenziell.

108 **C** Beschädigte Instrumente können brechen und Fragmente im Situs hinterlassen. Zudem ist eine sichere Aufbereitung nicht mehr gewährleistet.

109 **C** Einmalprodukte entfallen im Aufbereitungskreislauf und schließen Restkontamination aus. Sie sind aber teurer pro Anwendung und erzeugen mehr Abfall.

110 **B** Die Aufbereitung folgt einem festen, validierten Ablauf im Einbahnprinzip von unrein nach rein. Jeder Schritt wird dokumentiert, die Freigabe erfolgt durch qualifiziertes Personal.

111 **D** CSSD: Reinigung im RDG, Inspektion (Lupe, Sichtprüfung), Verpackung (Siegelbeutel/Container), Sterilisation (Autoklav 134°C), Freigabe, Lagerung. DGSV-Kurse Stufe I-III.

112 **B** Der Aufbereitungskreislauf verläuft: Reinigung und Desinfektion (meist maschinell im RDG), Kontrolle/Pflege/Funktionsprüfung, Verpackung, Sterilisation (z. B. Dampf 134 °C) und dokumentierte Freigabe. Nur so ist Sterilität sicher nachweisbar.

113 **D** Für OP-Instrumente die Körperhöhlen berühren (kritisch B): Sterilisation erforderlich. Desinfektion reicht nicht!

114 **C** Sterilgut gilt als unsteril, wenn die Verpackung beschädigt, durchfeuchtet oder geöffnet ist oder das Verfallsdatum überschritten wurde. Vor Gebrauch werden Unversehrtheit, Trockenheit, Indikator und Haltbarkeit kontrolliert.

115 **B** DGSV-Sterilgutaufbereitung: Reinigung (RDG), Inspektion, Verpackung (Folie/Container), Sterilisation (Dampf 134°C), Freigabe, Lagerung (trocken, staubfrei).

116 **A** Der Standard für thermostabile chirurgische Instrumente ist die Dampfsterilisation im Autoklav (gesättigter Wasserdampf, meist 134 °C bei entsprechendem Druck und Haltezeit). Thermolabile Produkte werden mit Niedertemperaturverfahren behandelt.

117 **B** Ein Behandlungsindikator (z. B. auf Verpackung oder Klebeband) zeigt durch Farbumschlag an, dass das Produkt einen Sterilisationsprozess durchlaufen hat. Zusätzlich werden Unversehrtheit, Trockenheit und Verfallsdatum geprüft.

118 **C** Die Dampfsterilisation erfolgt bei 134 Grad Celsius über mindestens 5 Minuten Haltezeit. Thermolabile Güter werden mit Niedertemperaturverfahren behandelt.

119 **C** Gebrauchtes Instrumentarium gilt als kontaminiert und wird sicher gesammelt und der Aufbereitung (AEMP/ZSVA) zugeführt. Antrocknen von Blut/Sekret wird vermieden (ggf. Vorbehandlung), da es die spätere Reinigung erschwert. Erst nach vollständiger Aufbereitung ist es wieder einsatzbereit.

OTA: Instrumente

120 **B** Fassende Instrumente sind Klemmen und Pinzetten. Chirurgische Pinzetten mit Häkchen greifen festes Gewebe, anatomische Pinzetten schonen empfindliche Strukturen.

121 **B** Die Metzenbaum-Schere hat lange, schlanke Branchen und schont empfindliches Gewebe. Fäden werden mit ihr nicht geschnitten, da die Schneide stumpf wird.

122 **A** Der Nadelhalter fasst die Nadel im hinteren Drittel. Er wird mit geschlossenem Maul und der Nadelspitze zum Operateur angereicht.

123 **A** Zu den Grundinstrumenten zählen Schneideinstrumente (Skalpell, Schere), fassende Instrumente (Pinzetten, Klemmen), Nadelhalter sowie Haken und Sperrer. Die OTA kennt Aufbau, Zweck und korrektes Anreichen dieser Instrumente.

124 **C** Die anatomische Pinzette (geriffelte, zahnlose Branchen) fasst Gewebe schonend, die chirurgische Pinzette (mit Zähnchen/Häkchen) gibt festeren Halt, z. B. an Haut/Faszie. Die Wahl richtet sich nach dem Gewebe.

125 **B** Instrumentierende OTA: steril eingekleidet, Instrumente anreichen, Instrumenten-/Tupfer-/Nadelzählung vor und nach OP, sterile Versorgung.

126 **B** Der Nadelhalter fixiert die gebogene chirurgische Nadel und ermöglicht das kontrollierte Nähen. Er gehört zu den chirurgischen Grundinstrumenten und wird passend zu Naht- und Nadelgröße gewählt.

127 **B** Wundhaken/Retraktoren (z. B. scharfe/stumpfe Haken, Roux-Haken, selbsthaltende Sperrer) halten die Wundränder auf und verdrängen Gewebe, damit der Operateur Sicht und Zugang zum OP-Gebiet hat.

128 **D** Die instrumentierende OTA richtet den sterilen Instrumentiertisch ein, behält den Überblick über Instrumente und Materialien, reicht sie dem Operateur zum richtigen Zeitpunkt an und führt gemeinsam mit dem Springer die Zählkontrolle durch.

129 **B** Der chirurgische Sauger entfernt Blut, Spülflüssigkeit und Sekret aus dem OP-Feld und sorgt so für freie Sicht und ein sauberes Arbeitsfeld. Die abgesaugte Menge kann zudem zur Beurteilung des Blutverlusts beitragen.

130 **A** Das Skalpell besteht aus Griff und aufsteckbarer Klinge. Es wird nie von Hand zu Hand gereicht, sondern über eine Ablageschale übergeben.

131 **C** Péan- und Overholt-Klemmen fassen das Gefäß, das anschließend ligiert oder koaguliert wird. Die Kocher-Klemme mit Häkchen dient dem Fassen derber Strukturen, nicht der Gefäßversorgung.

132 **C** Springer (unsteril): unterstützt steriles Team, öffnet Materialien und reicht an, Dokumentation, Implantat-Chargennummern dokumentieren, Telefon.

133 **C** Die OTA richtet den Instrumententisch, prüft Sterilgutindikatoren und Vollständigkeit und führt die Zählkontrolle von Instrumenten, Tupfern und Nadeln durch.

134 **A** Tuchklemmen sichern die Abdeckung gegen Verrutschen. Einmal fixiert, dürfen sie nicht mehr gelöst und neu gesetzt werden.

135 **B** Die Mayo-Schere ist kurz und kräftig gebaut. Die schlanke Metzenbaum-Schere ist für feine Präparation vorgesehen und wird nicht zum Fadenschneiden benutzt.

136 **A** Die Präparierschere (z. B. Metzenbaum) dient dem feinen Schneiden und dem stumpfen/scharfen Präparieren von Gewebe. Fäden werden dagegen mit einer robusteren Fadenschere durchtrennt, um die feine Präparierschere zu schonen.

137 **D** Klemmen wie die Péan- oder Kocher-Klemme dienen dem Fassen, Halten und Abklemmen von Gewebe oder Gefäßen (z. B. zur Blutstillung). Sie gehören zu den chirurgischen Grundinstrumenten und besitzen ein arretierbares Sperrgesperre.

138 **B** In der Neutralzone (z. B. Nierenschale) werden scharfe und spitze Instrumente abgelegt und aufgenommen, statt sie direkt von Hand zu Hand zu übergeben. Das senkt das Risiko von Schnitt- und Stichverletzungen im Team.

139 **C** Haken werden gehalten, Sperrer halten sich selbst. Sie halten Gewebeschichten zurück und geben dem Operateur Sicht und Zugang.

140 **C** Ein systematisch aufgebauter, übersichtlicher Instrumentiertisch ermöglicht zügiges, sicheres Anreichen, erleichtert die Zählkontrolle und reduziert Fehler – besonders wichtig in zeitkritischen oder komplexen Eingriffen.

OTA: OP-Technik

141 **D** Beim Schnellschnitt wird Gewebe gefroren, geschnitten und noch während der laufenden Operation vom Pathologen beurteilt. Das Ergebnis (z. B. Tumorart, Schnittränder) kann das weitere operative Vorgehen unmittelbar bestimmen.

142 **A** Der quere Unterbauchschnitt liegt in der Hautspaltlinie oberhalb der Symphyse. Er ist kosmetisch günstig und mechanisch stabil.

143 **A** Raspeln bereiten den Markraum für die Prothese vor. Beim Fräsen und Sägen wird gespült, um Hitzenekrosen des Knochens zu vermeiden.

144 **C** Bei der stumpfen Präparation werden Gewebeschichten entlang natürlicher Grenzen auseinandergedrängt. Das schont Leitungsbahnen, die scharf leicht durchtrennt würden.

145 **D** HF-Chirurgie (Monopolar/Bipolar): Neutralelektrode korrekt kleben (Monopolar), HF-Gerät vor OP prüfen, Herzschrittmacher beachten, keine brennbaren Substanzen im OP.

146 **D** Die Neutralelektrode leitet den Strom bei monopolarer HF-Chirurgie sicher ab. Sie muss großflächig, faltenfrei und mit vollem Kontakt auf gut durchbluteter, muskelreicher Haut nahe dem OP-Gebiet kleben – sonst drohen Verbrennungen.

147 **B** Im Schneidemodus (Cut) trennt ein kontinuierlicher Hochfrequenzstrom das Gewebe; im Koagulationsmodus (Coag) verschorft ein modulierter Strom das Gewebe und stillt Blutungen. Viele Geräte bieten Mischmodi (Blend).

148 **D** Bei der Ligatur wird das Gefäß mit einem Faden abgebunden, alternativ mit Clips versorgt. Größere Gefäße werden immer mechanisch versorgt.

149 **B** Da Vinci (Intuitive Surgical): OTA-Aufgaben: Patienten-Kart aufbauen/docken, steriles Draping, roboterassistierte Instrumente vorbereiten und wechseln, Endoskop vorbereiten.

150 **A** Bei der Blutleere wird die Extremität vor dem Aufpumpen der Manschette ausgewickelt (Blut ausgestrichen), sodass sie nahezu blutfrei ist. Bei der Blutsperre wird lediglich der arterielle Zufluss ohne vorheriges Auswickeln unterbunden.

151 **D** Bei der monopolaren Technik fließt der Strom vom Instrument durch den Körper zur Neutralelektrode (Cave korrekte Anlage!). Bei der bipolaren Technik fließt er nur zwischen den beiden Branchen (z. B. einer Pinzette) – gezielter und ohne Neutralelektrode, ideal in sensiblen Bereichen.

152 **A** Bei der Koagulation denaturiert Hochfrequenzstrom das Gewebeeiweiß und verschließt kleine Gefäße. Bei monopolarer Anwendung ist die korrekte Neutralelektrode entscheidend.

153 **C** Für die Laparoskopie wird CO_2 in die Bauchhöhle insuffliert (Pneumoperitoneum), um die Bauchdecke anzuheben und Sicht/Arbeitsraum für Kamera und Instrumente zu schaffen. Die OTA kennt Insufflator, Druckgrenzen und mögliche Kreislaufeffekte.

154 **B** Tourniquet/Blutleere: proximale Manschette → Extremität auswickeln (Esmarch) → Manschette aufblasen. Max. 90-120 Min. (Ischämiegefahr!). OTA: Dokumentation Anlagezeit und Druck.

155 **D** Laparoskopie: Trokare einbringen, CO_2-Pneumoperitoneum, Kamera (Karl Storz/Olympus) + Instrumente durch Trokare. OTA: Kamerasystem kennen, Gasversorgung, Bildschirm positionieren.

156 **A** Über Trokare werden Optik und Instrumente eingebracht, das CO_2-Pneumoperitoneum schafft den Arbeitsraum. Die OTA bereitet Kamera, Lichtquelle und Insufflator vor.

157 **B** Kleinere Zugänge bedeuten weniger Wundschmerz, geringere Infektionsrate und schnellere Mobilisation. Die Operationszeit kann jedoch länger sein.

158 **A** Chirurgischer Rauch (Diathermie) enthält Feinstaub sowie toxische und potenziell infektiöse/mutagene Bestandteile. Eine Rauchgasabsaugung schützt Personal und Patient – arbeitsschutzrelevant.

159 **A** Die mediane Laparotomie verläuft in der gefäßarmen Linea alba und lässt sich nach kranial und kaudal erweitern.

OTA: Naht & Wundverschluss

160 **A** Verbleibende Hohlräume füllen sich mit Sekret und begünstigen Serome und Infektionen. Die Faszie trägt die Hauptlast, die Haut wird spannungsfrei adaptiert.

161 **B** Polypropylen bleibt dauerhaft im Gewebe und wird für Gefäßnähte und Netzfixierungen genutzt. Hautnähte damit müssen gezogen werden.

162 **C** Alginate aus Braunalgen nehmen ein Vielfaches ihres Eigengewichts auf und bilden ein Gel. Bei trockenen Wunden sind sie ungeeignet.

163 **B** Der Faden verliert planmäßig an Reißkraft und wird abgebaut. Für dauerhaft belastete Strukturen ist er deshalb ungeeignet.

164 **C** Resorbierbares Nahtmaterial wird im Körper enzymatisch oder hydrolytisch abgebaut (z. B. für tiefe Schichten). Nicht-resorbierbares bleibt bestehen und muss bei Hautnähten in der Regel gezogen (entfernt) werden.

165 **C** Die intrakutane Naht verläuft fortlaufend in der Lederhaut, es entstehen keine Stichkanäle an der Oberfläche. Verwendet wird meist resorbierbares Material.

166 **D** USP (United States Pharmacopeia) gibt die genormte Fadenstärke an. Je mehr Nullen, desto dünner der Faden (z. B. ist 5-0 dünner als 3-0). Die Wahl richtet sich nach Gewebe und Belastung – feine Fäden z. B. für Gefäße oder Gesichtshaut.

167 **D** Die feuchte Wundbehandlung fördert Zellwanderung und Granulation. Trockene Kompressen kleben an und zerstören beim Wechsel neu gebildetes Gewebe.

168 **D** Die Redon-Drainage leitet über einen Sog (Vakuumflasche) Wundsekret und Blut aus dem Operationsgebiet ab. Das verringert Hämatom-/Serombildung und fördert die Wundheilung. Überwacht werden Sogfunktion, Menge und Aussehen des Sekrets.

169 **A** Purulentes Sekret ist das entscheidende Kriterium. Fibrinbeläge und geringe seröse Sekretion gehören zur normalen Heilung.

170 **D** Primär: saubere Wunde, Ränder adaptiert. Sekundär: Infektion/Gewebeverlust, offene Wunde, Granulation von innen. Tertiär: verzögerter Verschluss.

171 **C** Bei der Einzelknopfnaht wird jeder Stich separat geknotet (bei Nahtinsuffizienz hält der Rest), bei der fortlaufenden Naht werden mehrere Stiche in einem durchgehenden Faden gesetzt und am Ende verknotet (schneller, gleichmäßige Spannung). Die Wahl hängt von Gewebe und Situation ab.

172 **A** Die Wundklassifikation reicht von aseptisch/sauber (z. B. elektive OP ohne Eröffnung besiedelter Hohlorgane) über sauber-kontaminiert und kontaminiert bis septisch/schmutzig (z. B. bei Infektion). Sie beeinflusst Hygienemaßnahmen, Antibiotikagabe und das Infektionsrisiko.

173 **D** Resorbierbare Fäden werden hydrolytisch abgebaut und müssen nicht entfernt werden. Sie eignen sich für tiefe Schichten, die vorübergehend Halt brauchen.

OTA: Lagerung

174 **B** Die Rückenlage ist die häufigste OP-Lagerung. Der Arm wird maximal 90 Grad abduziert, um eine Schädigung des Plexus brachialis zu vermeiden.

175 **D** Die halbsitzende Position gibt freien Zugang zum Schultergelenk. Zu beachten ist der niedrigere zerebrale Perfusionsdruck durch die Höhendifferenz zum Herzen.

176 **D** Lagerungsschäden (Druck auf Nerven wie N. ulnaris oder N. peroneus, Dekubitus) werden durch sorgfältige Polsterung, physiologische Gelenkstellung, Vermeiden von Überstreckung und Schutz gefährdeter Stellen verhindert – die Lagerung wird dokumentiert.

177 **C** Die Seitenlage wird mit Stützen an Symphyse und Kreuzbein gesichert. Der unten liegende Arm und das Bein werden besonders sorgfältig gepolstert.

178 **D** Lagerungshilfsmittel (Gelkissen, Vakuummatratze, Polster) sorgen für eine stabile, physiologische und druckentlastende Lagerung des narkotisierten Patienten. So werden Druckstellen, Nerven- und Lagerungsschäden vermieden – gemeinsam mit korrekter Positionierung.

179 **D** OP-Lagerungen: Rücken (Standard), Bauch (Wirbelsäule, Knie), Seite (Thorax, Hüft-TEP), Steinschnitt (Urologie, Gynäkologie), Beach-Chair (Schulter). Druckprophylaxe und Dokumentation Pflicht!

180 **C** Eine perioperative Auskühlung (Hypothermie) erhöht das Risiko für Wundinfektionen, Gerinnungsstörungen, kardiale Ereignisse und verlängerte Aufwachzeiten. Wärmedecken, angewärmte Infusionen und Raumklima beugen vor.

181 **C** Besonders gefährdet sind Plexus brachialis, N. ulnaris am Ellenbogen und N. peroneus am Wadenbeinköpfchen. Die Schäden zeigen sich oft erst postoperativ.

182 **C** Ab etwa zwei Stunden OP-Dauer steigt das Risiko deutlich. Ringförmige Hilfsmittel sind kontraindiziert, da sie den Druck am Rand erhöhen.

183 **C** Bei Kippung des Tisches kann der narkotisierte Patient abrutschen. Gurte, Stützen und Kontrolle vor jeder Verstellung sind deshalb Pflicht.

184 **C** Die Lagerung verbindet den chirurgischen Zugang mit dem Schutz von Nerven, Gefäßen, Haut und Gelenken. Der narkotisierte Patient hat keine Schutzreflexe.

185 **D** Gepolstert werden Ellenbogen, Fersen, Kreuzbein und Wadenbeinköpfchen. Extremitäten werden weder überstreckt noch über die physiologische Grenze abduziert.

OTA: Sicherheit im OP

186 **A** OTA arbeiten nicht nur im OP, sondern u. a. in Endoskopieabteilungen, ambulanten OP-Zentren, Ambulanzen und in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP/ZSVA) – überall dort, wo instrumentelle und hygienische Kompetenz gefragt ist.

187 **C** Die WHO-Checkliste (Sign-in, Team-Time-Out, Sign-out) soll vermeidbare Fehler verhindern – etwa Patienten-, Eingriffs- oder Seitenverwechslungen –, indem das Team vor dem Schnitt zentrale Punkte gemeinsam bestätigt.

188 **D** Definierte Zuständigkeiten und feste Abläufe entlasten das Arbeitsgedächtnis. Das senkt die Fehlerrate besonders in kritischen Phasen.

189 **D** Nach dem Closed-Loop-Prinzip wird der Auftrag namentlich gegeben und laut wiederholt. Kritische Beobachtungen werden unabhängig von der Hierarchie angesprochen.

190 **D** Zählkontrolle: Vierprinzip (Instrumentierende + Springer). Vor OP-Beginn UND nach OP-Ende. Fehlendes Instrument → Suchaktion → ggf. intraoperatives Röntgen. Rechtlich: Fremdkörper = Kunstfehler.

191 **B** Die Zählkontrolle erfolgt mehrfach im Vier-Augen-Prinzip und wird dokumentiert. Bei Differenz wird gesucht und notfalls geröntgt, bevor die Wunde verschlossen wird.

192 **C** Jedes Präparat wird sofort mit Patientendaten und Entnahmeort gekennzeichnet und laut bestätigt. Eine Verwechslung kann zu falscher Therapie führen.

193 **B** Die perioperative Antibiotikaprophylaxe wird meist etwa 30–60 Minuten vor dem Hautschnitt gegeben, damit zum Zeitpunkt der Inzision ausreichende Gewebespiegel bestehen. Die rechtzeitige Gabe ist Teil des Team-Time-Outs (WHO-Checkliste).

194 **D** Implantatregister (seit 2021 EPRD für Endoprothesen): Chargennummer in Patientenakte einkleben. Bei Produktrückruf → betroffene Patienten identifizieren können.

195 **C** Fehlendes oder defektes Material verlängert die Narkosezeit und gefährdet den Patienten. Die Kontrolle erfolgt vor der sterilen Abdeckung.

196 **D** Der Springer öffnet Materialien, bedient Geräte, dokumentiert Implantatchargen und ist Bindeglied nach außen. Er bleibt unsteril.

197 **C** Das Time-out nach der WHO-Checkliste erfolgt bei Anwesenheit des gesamten Teams. Es verhindert Patienten-, Eingriffs- und Seitenverwechslungen.

198 **A** Der Röntgenkontrastfaden macht Kompressen/Bauchtücher im Röntgenbild sichtbar. Bei unstimmiger Zählkontrolle kann so ein versehentlich belassenes Tuch (Gossypiboma) lokalisiert werden – eine wichtige Sicherheitsmaßnahme neben der Zählkontrolle.

199 **C** Präparate müssen eindeutig beschriftet (Patient, Entnahmeort/Seite), dokumentiert und fachgerecht konserviert (z. B. in Formalin) an die Pathologie weitergegeben werden. Verwechslung oder Verlust können schwerwiegende Folgen haben.

200 **A** Skalpellklingen werden mit einem Instrument (z. B. Klemme) auf-/abgesetzt und über eine „Neutralzone“ (Ablagefeld/Nierenschale) angereicht statt Hand zu Hand. Das reduziert Schnitt-/Stichverletzungen und das Infektionsrisiko.

201 **C** OTA-Abschlussprüfung (ATA-OTA-APrV): alle 3 Teile mindestens 'ausreichend'. Praktische Prüfung: komplette OP-Situation von Vor- bis Nachbereitung. Bezirksregierungen NRW zuständig.

202 **C** Das Sign-out erfolgt am Ende des Eingriffs vor dem Verlassen des Saals: Bestätigt werden u. a. die durchgeführte Prozedur, die vollständige Zählkontrolle (Instrumente, Tücher), die Beschriftung der Präparate und aufgetretene Probleme.

203 **D** Die instrumentierende OTA ist steril eingekleidet, richtet den Instrumententisch, reicht vorausschauend an und führt die Zählkontrolle durch.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.